

Bunga Rampai

EDUKASI KESEHATAN GIGI UNTUK MASYARAKAT

Ika Ifitri
Merniwati Sherly Eluama
Arnetty

Editor: Arnetty



BUNGA RAMPAI: EDUKASI KESEHATAN GIGI UNTUK MASYARAKAT

Penulis:

drg. Ika Ifitri, MDSc.

Merniwati Sherly Eluama, S.Kp.G., MDSc.

drg. Arnetty, M.Kes.

Editor:

drg. Arnetty M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Edukasi Kesehatan Gigi Untuk Masyarakat

Penulis: Drg. Ika Ifitri, MDSc.

Merniwati Sherly Eluama, S.Kp.G., MDSc.

Drg. Arnetty, M.Kes.

Editor: drg. Arnetty M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-35-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul ***Bunga Rampai: Edukasi Kesehatan Gigi untuk Masyarakat*** ini dengan baik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut di berbagai kelompok usia. Adapun isi dari buku ini mencakup tiga pokok bahasan utama, yaitu: edukasi mengenai bahaya kebiasaan buruk yang dapat merusak kesehatan gigi, penyuluhan kesehatan gigi bagi lanjut usia, serta penyuluhan kesehatan gigi bagi anak-anak dan remaja. Ketiga topik tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan edukatif yang mendesak dan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Penulis berharap, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, tenaga medis, pendidik, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Besar harapan penulis, melalui buku ini dapat terbangun kesadaran yang lebih tinggi di tengah masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan gigi sejak usia dini hingga lanjut usia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 EDUKASI TENTANG BAHAYA KEBIASAAN BURUK PADA GIGI.....	1
drg. Ika Ifitri, MDSc.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Anatomi Gigi.....	3
C. Kebiasaan Buruk yang Berdampak pada Kesehatan Gigi.....	5
D. Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada kesehatan gigi.....	8
E. Pentingnya Edukasi dan Kebiasaan Baik.....	9
F. Simpulan	13
G. Referensi.....	14
H. Glosarium.....	17

CHAPTER 2 EDUKASI KESEHATAN GIGI UNTUK MASYARAKAT PENYULUHAN KESEHATAN GIGI UNTUK LANSIA.....	19
Merniwati Sherly Eluama, S.Kp.G., MDSc.	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Perubahan Gigi dan Mulut pada Lansia	21
C. Perubahan patologis rongga mulut pada lansia	22
D. Cara Merawat Gigi dan Mulut pada Lansia.....	27
E. Penggunaan Gigi Tiruan pada Lansia.....	31

F. Penyuluhan Kesehatan Gigi untuk Lansia.....	33
G. Beberapa Materi Yang Relevan Sehingga Perlu Disampaikan Dalam Penyuluhan Kesehatan Gigi Untuk Lansia	34
H. Peran tenaga Kesehatan gigi dalam peningkatan kesehatan gigi lansia	37
I. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	37
J. Referensi.....	39

CHAPTER 3 PENYULUHAN KESEHATAN GIGI

UNTUK ANAK-ANAK DAN REMAJA..... 41

Drg. Arnetty, M.Kes.....	41
A. Pendahuluan/Prolog.....	41
B. Struktur Gigi.....	44
C. Fungsi Gigi.....	48
D. Masalah Kesehatan Gigi Anak-anak dan Remaja	49
E. Faktor Penyebab Masalah Kesehatan Gigi	52
F. Cara Menjaga Kesehatan Gigi Anak Anak dan Remaja	56
G. Membangun Rutinitas Perawatan Gigi Anak dan Remaja	61
H. Mengajarkan Anak Disiplin dalam Menjaga Kesehatan Gigi.....	64
I. Peran Orang Tua dan Guru dalam Edukasi Kesehatan Gigi Anak dan Remaja.....	67
J. Referensi.....	71
K. Glosarium.....	78

PROFIL PENULIS 81

CHAPTER 1

EDUKASI TENTANG BAHAYA KEBIASAAN BURUK PADA GIGI

drg. Ika Ifitri, MDSc.

A. Pendahuluan

Kesehatan gigi yang baik dapat mencegah berbagai penyakit gigi dan gusi, seperti karies dan periodontitis. Menjaga kebersihan mulut, termasuk menyikat gigi secara teratur dan menggunakan benang gigi, dapat mengurangi risiko penyakit ini (Sanz, M & Van Winkelhoff, A.J (2018). Kesehatan gigi berhubungan langsung dengan kesehatan umum. Penyakit gigi dapat menyebabkan infeksi yang dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh, berpotensi memicu masalah kesehatan yang lebih serius seperti penyakit jantung (Lokkhardt, P.B & Bolger, A.F (2012). Kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Masalah gigi seperti kehilangan gigi atau cacat gigi, dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kualitas hidup seseorang. Kesehatan gigi yang baik berkontribusi pada penampilan fisik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Pentingnya pemeriksaan rutin secara rutin sangat penting untuk mendeteksi masalah gigi sejak dini. Banyak masalah gigi tidak menunjukkan gejala pada awalnya sehingga pemeriksaan rutin dapat membantu mencegah kerusakan yang lebih serius (American Dental

Association, 2020). Kesehatan gigi yang buruk dapat menyebabkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Pengobatan untuk penyakit gigi dapat menjadi mahal, dan pencegahan melalui perawatan gigi yang baik dapat mengurangi beban ekonomi secara keseluruhan (Righolt, C. H., et al. 2016).

Anak-anak merupakan golongan orang yang memiliki banyak permasalahan kesehatan. Dari mulai masalah kesehatan gigi dan mulut hingga ke tubuh bagian dalam. Hal yang harus diingat, jangan pernah menyepelekan sekecil apapun yang berhubungan dengan kesehatan gigi. Bisa jadi, hal yang asalnya kecil menjadi serius dikemudian hari. Kesehatan gigi dan mulut anak serta permasalahannya juga jangan luput dari perhatian. Hal-hal yang menyangkut kesehatan gigi dan mulut anak serta permasalahannya banyak yang berhubungan dengan sesuatu yang serius (Arifin, M.S & Rohan, H.H, 2016).

Dengan menjaga kesehatan gigi, bukan hanya kesehatan mulut yang terjaga, tetapi juga kesehatan umum dan kualitas hidup seseorang. Pemeriksaan rutin dan perawatan gigi yang baik sangat penting untuk mencapai hal tersebut. Psikologi anak memiliki peran penting dalam kesehatan gigi dan mulut karena kondisi emosional dan perilaku anak dapat mempengaruhi perawatan gigi yang efektif. Anak-anak cenderung merasa takut atau cemas saat mengunjungi dokter gigi sehingga pendekatan-pendekatan yang ramah penuh pengertian dan komunikatif sangat diperlukan. Psikologi anak juga

membantu memahami kebiasaan buruk seperti mengisap jari, mengempeng atau takut menyikat gigi yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi (Arifin, M.S & Rohan, H.H, 2016).

Pentingnya edukasi sejak dini kepada anak tentang kebiasaan menjaga kesehatan gigi, seperti menyikat gigi dua kali sehari dan makan makanan sehat, juga berhubungan dengan cara psikologi anak diimplementasikan. Pendekatan dengan cerita permainan atau visual menarik dapat membantu anak lebih termotivasi dan merasa nyaman menjaga kebersihan gigi dan mulut mereka. Dokter gigi anak biasanya memiliki pelatihan khusus untuk memahami kebutuhan psikologis anak dalam menciptakan pengalaman perawatan positif (Rahmadhan, A.G, 2010).

B. Anatomi Gigi

Gigi merupakan bagian terkeras dari tubuh yang terdapat di dalam mulut, berfungsi sebagai alat pencernaan mekanik. Bagian-bagian gigi;

1. Mahkota Gigi: bagian gigi yang nampak dari luar, bagian ini dilapisi oleh lapisan pelindung gigi disebut email,
2. Leher gigi: bagian yang sudah tertanam di dalam gusi, terdapat di bawah mahkota dan di atas akar gigi.
3. Akar gigi: bagian tertanam di bawah rahang dan tidak tampak dari luar gigi, masing-masing jenis gigi pada manusia memiliki jumlah akar gigi yang berbeda-beda.

Struktur gigi manusia terdiri dari;

1. Email: Bagian terkeras terletak pada bagian mahkota yang berfungsi sebagai pelindung,
2. Dentin: memiliki struktur seperti tulang namun lebih keras dari tulang karena memiliki konsentrasi kalsium yang lebih tinggi, sehingga sering disebut juga tulang gigi. Dentin merupakan struktur terluas pada gigi karena melapisi seluruh tubuh gigi, dari mahkota sampai akar,
3. Pulpa/rongga pulpa: merupakan jaringan lunak pada tengah gigi yang berbentuk rongga dan terisi oleh pembuluh darah dan pembuluh saraf. Pulpa berfungsi untuk memberikan nutrisi pada gigi karena memiliki pembuluh darah, juga berfungsi untuk mengidentifikasi apabila terdapat zat asing dalam gigi karena memiliki pembuluh saraf. Pulpa juga berfungsi untuk membentuk lapisan dentin,
4. Sementum: bagian gigi yang melapisi akar gigi. Sementum berfungsi untuk menghubungkan gigi dengan rahang tempatnya tumbuh. Struktur sementum tidak sekeras email. Semen akan semakin tebal seiring bertambahnya usia (Arifin, M.S & Rohan, H.H, 2016).

Pada manusia ditemui 4 (empat) macam gigi:

1. Gigi seri: berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan.
2. Gigi taring: berfungsi untuk mengoyak makanan.
3. Gigi geraham kecil: berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan.

4. Gigi geraham besar: berfungsi untuk menggilas, melumat, menghancurkan dan menghaluskan makanan (Arifin, M.S & Rohan, H. H, 2016).

C. Kebiasaan Buruk yang Berdampak pada Kesehatan Gigi

Kebiasaan merupakan suatu hal yang sering dilakukan, sehingga seseorang tidak perlu memikirkan lagi untuk melakukannya, hal ini berjalan dengan sendirinya. Suatu kebiasaan akan disebut sebagai kebiasaan buruk, apabila bisa menimbulkan efek yang negative untuk individu tersebut. Menghilangkan kebiasaan buruk sama pentingnya dengan memelihara kebiasaan baik. Beberapa kebiasaan buruk yang berdampak kepada kesehatan gigi dan mulut;

1. Merokok: merokok merupakan kebiasaan yang paling buruk dan bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang, yang dapat menyebabkan pewarnaan/staining pada gigi dan mukosa mulut serta bau mulut. Akibat yang paling parah dapat menyebabkan kanker rongga mulut.
2. Bruxism: kebiasaan suka menggesek-gesekan gigi atau mengatupkan rahang dengan kuat. Biasanya ini dilakukan sewaktu seseorang dalam kondisi stress, marah, cemas, frustrasi, atau tegang. Akibat yang paling parah dapat mengakibatkan email gigi menjadi tipis bahkan menimbulkan keretakan pada struktur gigi, sehingga gigi akan terasa linu ketika dibawa makan atau minum. Biasanya hampir semua permukaan kunyah gigi bisa rusak akibat kebiasaan ini.

3. Mengunyah makanan disatu sisi rahang: kebiasaan ini dapat diakibatkan karena disalah satu sisi terasa sakit atau tidak nyaman dibawa berfungsi. Jika kebiasaan ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan timbulnya masalah pada sendi rahang dan juga pada sisi yang tidak digunakan akan terjadi penumpukan sisa makanan.
4. Menggigit benda keras: kebiasaan menggigit benda keras, seperti; pensil, pulpen, kuku, es batu, atau benda-benda keras yang lain, dapat mengakibatkan pengikisan atau keretakan pada struktur gigi dan dapat juga mengakibatkan gigi patah, dan 5) Gigi sebagai gunting: kebiasaan ini contohnya membuka tutup botol dengan gigi, menyobek kemasan makanan, atau memotong label baju dengan gigi. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada gigi dan melemahkan struktur gigi dan merusak enamel (Rahmadhan, A.G, 2010).

Beberapa kebiasaan buruk yang dapat berdampak negative pada kesehatan gigi;

1. Menyikat gigi dengan cara yang salah: menyikat gigi yang terlalu keras atau menggunakan sikat gigi yang berbulu kasar dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan resesi gusi. Penelitian menunjukkan bahwa teknik menyikat gigi yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan gigi (McGuire, J.S., & Nunn, M.E. 1996).
2. Mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan: Gula adalah salah satu penyebab utama

kerusakan gigi. Bakteri di dalam mulut mengubah gula menjadi asam, yang dapat merusak enamel gigi. Konsumsi berlebihan makanan manis meningkatkan risiko pembentukan plak dan karies (Moynihan, P.J., & Kelly, S.A. 2014).

3. Merokok dan penggunaan tembakau: Merokok tidak hanya berkontribusi pada penyakit periodontal tetapi juga meningkatkan risiko kanker mulut. Tembakau mengurangi aliran darah ke gusi, yang dapat menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi (Schou, L., et al. 2003)
4. Menggigit kuku: kebiasaan menggigit kuku dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, termasuk retak dan patah. Selain itu, bakteri yang ada di bawah kuku dapat masuk ke dalam mulut dan meningkatkan risiko infeksi (Reddy, R.S, et al. 2016).
5. Menggunakan gigi sebagai alat: banyak orang menggunakan gigi untuk membuka kemasan atau memegang benda, yang dapat menyebabkan gigi retak atau patah. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada gusi dan jaringan di sekitarnya (Caffesse, R.G., et al. (2010).
6. Kurangnya perawatan gigi rutin: tidak melakukan pemeriksaan gigi secara teratur dapat menyebabkan masalah gigi yang lebih serius, seperti penyakit gusi dan kerusakan gigi yang tidak terdeteksi. Perawatan gigi rutin penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut (American Dental Association. 2020).

D. Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada kesehatan gigi

Kebiasaan buruk pada gigi dapat memberikan dampak negative baik jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa dampak negatif jangka pendek;

1. Peningkatan resiko karies gigi: kebiasaan buruk seperti mengonsumsi makanan manis dan tidak menjaga kebersihan gigi dapat menyebabkan penumpukan plak, yang berkontribusi pada pembentukan karies gigi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula yang tinggi berhubungan dengan peningkatan insiden karies gigi, terutama dikalangan anak-anak (Moynihan & Kelly, 2014).
2. Peradangan gusi (gingivitis): kebiasaan buruk seperti tidak menyikat gigi secara teratur dan merokok dapat menyebabkan peradangan gusi . gingivitis merupakan tahap awal penyakit periodontal yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan pendarahan gusi saat menyikat gigi (Peterson, 2005)
3. Sensitivitas gigi: kebiasaan buruk seperti menggosok gigi terlalu keras atau menggunakan pasta yang terlalu abrasif dapat menyebabkan enamel gigi terkikis, yang mengarah pada sensitivitas gigi. Ini dapat menyebabkan rasa nyeri saat mengonsumsi makanan atau minuman panas, dingin, atau manis (Lindhe et al., 2008).

Sementara dampak jangka panjang, dapat menyebabkan;

1. Penyakit periodontal: jika kebiasaan buruk tidak diatasi, maka akan dapat berkembang menjadi oenyakit

periodontal yang lebih serius, yang dapat menyebabkan kehilangan jaringan pendukung gigi dan bahkan kehilangan gigi. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit periodontal berhubungan dengan berbagai kondisi kesehatan sistemik, termasuk penyakit jantung (Petersen dan Ogawa, 2012).

2. Rongga Mulut yang tidak sehat: kebiasaan buruk yang terus menerus dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut yang kronis, seperti abses, infeksi, dan kerusakan gigi permanen. Ini dapat mengakibatkan biaya perawatan yang tinggi dan kualitas hidup yang menurun (Kassebaum et al, 2017).
3. Dampak Psikologis: Masalah gigi yang diakibatkan yang diakibatkan oleh kebiasaan buruk dapat mempengaruhi kesehatan mental, seperti rasa percaya diri yang rendah akibat penampilan gigi yang buruk. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kesehatan mulut dan kualitas hidup, termasuk dampak emosional (Friedman et al, 2019).

Dengan memahami dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebiasaan buruk pada gigi, individu dapat lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka.

E. Pentingnya Edukasi dan Kebiasaan Baik

Edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut sangat penting dilakukan karena edukasi sangat berperan penting dalam mencegah berbagai masalah kesehatan gigi dan

mulut, seperti gigi berlubang, penyakit gusi, dan bau mulut. Selain itu, kesehatan gigi yang baik juga akan memberikan kontribusi pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, karena infeksi gigi dan gusi dampak pada kesehatan tubuh secara umum. Beberapa edukasi. Pentingnya edukasi tentang kesehatan gigi

1. Pencegahan masalah kesehatan gigi: dengan edukasi, anda memahami cara mencegah kerusakan gigi, gusi bengkak, hingga penyakit periodontal. Contohnya; mengerti pentingnya menyikat gigi dua kali sehari dan flossing untuk menghilangkan plak.
2. Mengurangi risiko penyakit serius: masalah pada gigi dapat memicu penyakit lain, seperti infeksi jantung (endocarditis). Edukasi membantu mencegah komplikasi lebih jauh.
3. Meningkatkan kepercayaan diri: gigi yang sehat dan bersih memberikan senyuman yang indah, meningkatkan rasa percaya diri.
4. Mengurangi biaya kesehatan: dengan memahami cara menjaga kesehatan gigi sejak dini. Anda bisa menghindari biaya besar untuk perawatan seperti tambal gigi atau pemasangan mahkota.
5. Menjaga kesehatan gigi sejak dini: edukasi yang diberikan sejak dini dapat membentuk kebiasaan sehat dalam menjaga kebersihan gigi. Sebuah studi oleh haleem et al (2016) menemukan program edukasi kesehatan gigi disekolah efektif dalam meningkatkan kebiasaan menyikat gigi dan mengurangi karies gigi

pada anak-anak (Haleem, A. Siddiqui, M.I, Khan, A.A, 2016)

Edukasi tentang kebiasaan baik dalam merawat kesehatan gigi sangat penting untuk mencegah berbagai masalah gigi dan gusi di masa depan. Dengan menerapkan kebiasaan sehat ini, individu dapat menjaga kesehatan mulut mereka dengan lebih baik. Edukasi dan kebiasaan baik pada kesehatan gigi meliputi;

1. Menyikat gigi secara teratur: menyikat gigi setidaknya dua kali sehari (pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur) dengan menggunakan pasta yang mengandung fluoride. Hal ini merupakan suatu cara yang efektif dalam mencegah kerusakan gigi dan penyakit jaringan pendukung gigi. Fluoride membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah terjadinya demineralisasi enamel (ADA, 2021).
2. Memeriksa gigi ke tenaga dokter gigi secara berkala: mengunjungi dokter gigi setidaknya dua kali setahun untuk pemeriksaan dan pembersihan gigi secara profesional dapat membantu mendeteksi masalah gigi lebih awal dan dapat mencegah komplikasi lebih lanjut (ADA, 2021).
3. Menggunakan Pelindung Gigi saat Olahraga: Menggunakan pelindung gigi saat berolahraga dapat melindungi gigi dari cedera akibat benturan. Ini sangat penting bagi atlet atau individu yang terlibat dalam olahraga kontak (ADA, 2021).

4. Menggunakan benang gigi: menggunakan benang gigi setiap hari dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan dan plak yang terperangkap di antara gigi, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Penggunaan benang gigi sangat penting untuk menjaga kesehatan gusi (NIDCR, 2020).
5. Membatasi Konsumsi Gula: Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula dapat membantu mencegah kerusakan gigi. Bakteri di mulut memanfaatkan gula untuk menghasilkan asam yang dapat merusak enamel gigi (WHO, 2015).
6. Menghindari Kebiasaan Buruk: Kebiasaan seperti menggigit kuku, menggunakan gigi sebagai alat, atau merokok dapat merusak gigi dan gusi. Menghindari kebiasaan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mulut (Mayo clinic, 2021)

Edukasi tentang bahaya kebiasaan buruk ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta mencegah berbagai masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari, diantaranya;

1. Menyikat gigi yang tidak teratur: Kebiasaan menyikat gigi yang tidak teratur dapat menyebabkan penumpukan plak dan karang gigi, yang berkontribusi pada masalah gigi seperti gigi berlubang dan penyakit gusi (ADA, 2021).
2. Mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan: Makanan dan minuman yang tinggi gula

dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Bakteri dalam mulut mengubah gula menjadi asam, yang dapat merusak enamel gigi (WHO, 2015).

3. Penggunaan obat kumur yang mengandung alkohol: Beberapa obat kumur yang mengandung alkohol dapat mengeringkan mulut, yang dapat mengurangi produksi saliva. Saliva penting untuk melindungi gigi dari kerusakan (Lemos, J.A, et all, 2019).
4. Merokok dan penggunaan tembakau: Merokok dan penggunaan produk tembakau dapat menyebabkan penyakit gusi, kerusakan gigi, dan kanker mulut. Kebiasaan ini juga dapat menyebabkan bau mulut yang tidak sedap (NIDCR, 2020).
5. Menggigit kuku atau objek keras: Kebiasaan menggigit kuku atau mengunyah objek keras seperti pensil dapat menyebabkan keretakan atau patahnya gigi. Ini juga dapat merusak gusi dan struktur mulut lainnya (AAPD, 2016).
6. Tidak menggunakan pelindung gigi saat berolahraga: Tidak menggunakan pelindung gigi saat berpartisipasi dalam olahraga kontak dapat meningkatkan risiko cedera gigi. Pelindung gigi dapat membantu melindungi gigi dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan (ADA, 2017) .

F. Simpulan

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kualitas hidup seseorang. Kebiasaan buruk seperti

menggigit kuku, menggertakkan gigi, merokok, serta konsumsi berlebihan makanan dan minuman manis dapat menyebabkan kerusakan serius pada gigi, gusi, dan struktur rahang. Dampak dari kebiasaan buruk ini tidak hanya bersifat jangka pendek seperti gigi berlubang, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Pencegahan dimulai dengan edukasi sejak dini mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan dampak negatif dari kebiasaan buruk. Selain itu, penerapan kebiasaan positif seperti menyikat gigi dengan benar, menghindari konsumsi berlebihan makanan manis, dan rutin memeriksakan gigi ke dokter sangatlah penting. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang tepat, kita dapat memutus rantai kebiasaan buruk serta menciptakan generasi yang lebih sehat. Komitmen bersama antara individu, keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dengan demikian, diharapkan tingkat masalah kesehatan gigi dapat berkurang secara signifikan.

G. Referensi

American Dental Association. (2020). *"Oral Health Topics: Preventive Dentistry."*

American Academy of Pediatric Dentistry. (2016). "Policy on the Role of the Pediatric Dentist in the Prevention of Oral Disease".

- American Dental Association (ADA). (2021). "Brushing Your Teeth
- American Dental Association. (2017). "Protect Your Smile: Mouthguards".
- Arifin, M.S, & Rohan, H.H, (2016), Pentingnya Mengenal Kesehatan Gigi, dan Problematika Gigi, Deepublish, Yogyakarta, ed.1,
- Caffesse, R. G., et al. (2010). *"Oral Health Risks Associated with Using Teeth as Tools."* *Journal of American Dental Association*.
- Friedman, P.K, et al. (2019). The relationship Between Oral Health and Quality of Life: a systemic review: *Journal of Dental Hygiene*, 93(2), 4-12.
- Haleem, A., Siddiqui, M. I., Khan, A. A. (2016). School-based strategies for oral health education of adolescents—A cluster randomized controlled trial. *BMC Oral Health*, 16(1), 113.)
- Kassebaum, N.J, Smith, A.G.C, Bernabe, E, et al. (2017). Global, regional, and national prevalence, incidence, and years lived with disability for oral conditions in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Journal of dental Research*, 96(4), 380-387.
- Lemos, J. A., et al. (2019). "Salivary flow rate and the use of mouthwashes: the relationship with oral health".
- Lindhe, J. Lang, N.P, & Karring, T. (2008): *Clinical Periodontology and Implant dentistry*, Wiley-Blackwell.

- Lockhart, P. B., & Bolger, A. F. (2012). Periodontal disease and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. *Circulation*, 125(20), 2466-2478.
- Mayo Clinic. (2021). "Dental health: Tips for preventing tooth decay."
- McGuire, J. S., & Nunn, M. E. (1996). "Toothbrushing and Gingival Health: A Review of the Literature." Journal of Periodontology.*
- Moynihan, P. J., & Kelly, S. A. (2014). "Effect on Caries of Restricting Sugars Intake: Systematic Review to Inform WHO Guidelines." Journal of Dental Research.*
- Moynihan, P.J & Kelly, S.A.M. (2014). Effect on caries of restricting sugars intake. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 42(1), 1-16.
- National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR). (2020). "Flossing: A Key to Healthy Gums."
- National Institute of Dental and Craniofacial Research. (2020). "Tobacco Use and Oral Health".
- Peterson, P.E, & Ogawa, H (2012). The Global Burden of Periodontal disease: towards integration with general health. *Bulletin of the World Health Organisation*, 90 (1), 46-51.
- Peterson, P.E, (2005). Defining a global public health agenda for periodontal disease. *Journal of Periodontology*, 76(12), 2018-2085.
- Rahmadhan, A.G, (2010). *Serba Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut*, Bukune, Jagakarsa, ed.1, 47-54.

Reddy, R. S., et al. (2016). "Habitual Nail Biting: A Study of its Effects on Oral Health." *Journal of Indian Society of Periodontology*.

Righolt, C. H., et al. (2016). Economic impact of oral diseases in the United States. *Journal of Dental Research*, 95(2), 202-208.

Sanz, M., & van Winkelhoff, A. J. (2018). Periodontitis and systemic diseases: the role of oral health in preventing systemic disease. *Nature Reviews Disease Primers*, 4(1), 1-16.

Schou, L., et al. (2003). "The Effect of Tobacco on Oral Health." *Journal of Clinical Periodontology*.

Tsakos, G., & Marcenes, W. (2006). The impact of oral health on quality of life. *Journal of Dental Research*, 85(2), 164-168.

World Health Organization (WHO). (2015). "Sugars intake for adults and children."

H. Glosarium

Abrasive: bahan yang dapat mengikis, menggerus, dan menghilangkan zat yang menempel pada gigi

Fluoride: mineral yang dapat melindungi gigi

Flossing: tindakan membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan dengan benang gigi

Karies: penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan aktifitas jasad renik yang ada dalam suatu karbohidrat yang diragikan

Plak: lapisan tipis dan lengket di permukaan gigi yang mengandung bakteri

Remineralisasi: proses pergantian kalsium dan pospat yang terkikis dari email gigi

Saliva: cairan mulut yang kompleks, tidak berwarna, dan disekresikan oleh kelenjar ludah mayor dan minor untuk mempertahankan homeostatis di dalam rongga mulut.

CHAPTER 2

EDUKASI KESEHATAN GIGI UNTUK MASYARAKAT PENYULUHAN KESEHATAN GIGI UNTUK LANSIA

Merniwati Sherly Eluama, S.Kp.G., MDSc.

A. Pendahuluan

Penuaan merupakan suatu proses yang berjalan secara perlahan namun terus berubah, di mana setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami konsep penuaan yaitu apa yang dapat dipertimbangkan secara valid dan yang membentuk pandangan negative dari para profesional tenaga kesehatan gigi dapat membantu memenuhi kebutuhan individu lansia melalui metode perawatan gigi yang tepat.

Geriatri dan gerontologi adalah istilah berbeda dalam kesehatan lansia. Geriatri fokus pada penyakit dan perawatan lansia, sedangkan gerontologi mempelajari proses penuaan dan faktor-faktornya. Gerontolog mengelompokkan lansia dalam kategori usia: muda-tua (65-74 tahun), setengah baya (75-84 tahun), dan tua sekali (85+ tahun), dengan beberapa ahli menambahkan kategori "tua baru" (55-64 tahun) dan "tua sekali" (95+ tahun). Pengelompokan usia sebaiknya berlandaskan kemampuan

fungsional, bukan usia kronologis, mengingat banyak lansiamampu beraktifitas secara mandiri.

Tenaga kesehatan gigi dihadapkan pada berbagai tantangan ketika memberikan pelayanan kepada orang lanjut usia, disebabkan oleh perbedaan biologis, psikologis, dan sosial yang luas dalam kelompok ini. Orang tua merupakan kelompok yang sangat beragam karena pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kesehatan seseorang pada waktu tertentu adalah hasil dari faktor fisiologis, kondisi lingkungan, elemen psikososial, serta tingkat keterampilan dan pilihan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap individu lansia perlu dievaluasi kebutuhannya secara terpisah, tanpa mengikuti asumsi atau stigma yang telah ada sebelumnya. Kebutuhan perawatan kesehatan untuk orang tua mencakup spektrum yang lengkap, mulai dari individu yang sehat hingga yang mengalami penyakit berat. Tenaga kesehatan gigi sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan pelaksanaan perawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan medis, sosial, dan psikologis yang rumit dan beragam, serta memerlukan pengelolaan berbagai jenis layanan medis yang saling terkait. Ada sejumlah faktor yang berhubungan dengan perawatan gigi bagi orang lanjut usia. Faktor-faktor tersebut meliputi: perubahan karena penuaan, kondisi kesehatan, penggunaan obat, serta administrasi perawatan.

B. Perubahan Gigi dan Mulut pada Lansia

Perubahan tubuh secara umum pada lansia, khususnya yang mengenai rongga mulut adalah:

1. Jaringan lunak mulut

- a. Penurunan kemampuan Indera pengecap.
- b. Peningkatan besar dan jumlah bintik Fordyce (kelenjar sebacea ektopik yang membesar di membran mukosa mulut, bibir, pipi, dan lidah), varises di lidah, serta papila foliata (mirip dengan daun).
- c. Penurunan ketebalan epitel dan jaringan mukosa.
- d. Penurunan produksi saliva (xerostomia) dan perubahan dalam komposisinya.

2. Jaringan keras gigi

- a. Kehilangan jaringan keras gigi merupakan bagian alami dari proses penuaan, menyebabkan atrisi, abrasi, dan erosi.
- b. Enamel memiliki permeabilitas rendah
- c. Sementum terus mengalami pengendapan, terutama di bagian apikal akar.
- d. Dentin sekunder meningkat, meskipun laju pengendapan menurun seiring bertambahnya usia.
- e. Dentin menjadi lebih transparan dan ditandai oleh penyempitan lumen tubulus, peningkatan kalsifikasi, dan penurunan sensitivitas.
- f. Pada pulpa gigi, meningkatnya fibrosis dan penurunan pembuluh darah mengurangi daya pertahanan, meskipun tetap vital.

- g. Volume pulpa menyusut karena pengendapan dentin sekunder, dan kalsifikasi pulpa meningkat.

3. Periodonsium

Peningkatan fibrosis pada jaringan periodontal berhubungan dengan usia, yang mengarah pada kerusakan jaringan. Penuaan menyebabkan perubahan pada komposisi plak dan respons periodonsium, termasuk penurunan mikroorganisme hidup, peningkatan spirochaetes, dan penurunan streptokokus. Meskipun kerusakan periodontal cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, pengaruh perubahan komposisi plak terhadap kerusakan belum jelas. Penelitian menunjukkan bahwa peradangan di periodonsium meningkat dengan usia, tetapi risiko penyakit periodontal lebih mempengaruhi laju kerusakan dibandingkan durasi plak. Selain itu, terjadi penurunan dalam seluleritas, vaskularitas, regenerasi sel, serta sintesis kolagen dan protein seiring bertambahnya usia.

C. Perubahan patologis rongga mulut pada lansia

1. Penyakit periodontal

Penyakit periodontal, walaupun sering dikaitkan dengan peningkatan usia, tidak seharusnya dianggap sebagai konsekuensi alami penuaan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kehilangan dukungan periodontal dapat terjadi dengan bertambahnya usia, faktor-faktor lain seperti kebersihan mulut yang buruk dan pola makan yang tidak sehat berperan lebih besar.

Resesi gusi, yang umum terjadi pada orang tua, meningkatkan risiko karies akar.

2. Karies akar

Karies akar menjadi isu kesehatan gigi penting pada populasi usia lanjut, terutama karena permukaan akar yang terekspos akibat resesi gusi. Meskipun lebih sering ditemukan pada individu yang lebih tua, tidak semua permukaan akar yang terbuka mengalami karies akar. Permukaan akar lebih rentan dibandingkan enamel, dengan pH kritis untuk demineralisasi dentin yang lebih tinggi. Faktor utama penyebab karies akar meliputi permukaan akar yang rentan akibat kehilangan perlekatan, karbohidrat yang dapat difermentasi yang diubah oleh bakteri menjadi asam, dan biofilm plak gigi dengan mikroflora, terutama *Streptococcus mutans* dan *Actinomyces*. Waktu juga berperan penting, karena pH rendah meningkatkan risiko demineralisasi permukaan akar lebih cepat dibandingkan enamel, dengan batas pH kritis untuk demineralisasi enamel dan dentin berada di antara 5,2 hingga 6,5. Faktor sekunder penyebab karies akar meliputi air liur, yang berfungsi melindungi dengan menetralkan pH, dan fluorida, yang menghambat glikolisis serta meningkatkan remineralisasi. Kekasaran permukaan akar berdampak pada pembentukan plak, dan lokasi gigi juga mempengaruhi kerentanan terhadap karies, terutama gigi insisivus yang paling tahan.

3. Xerostomia

Xerostomia atau mulut kering, sering disalahpahami sebagai fenomena normal seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan penurunan aliran saliva minimal pada individu sehat tanpa obat, dengan sekresi saliva tidak terstimulasi berkisar 0,3 hingga 0,5 ml per menit. Namun, pasien xerostomia dapat mengalami penurunan drastis hingga kurang dari 0,1 ml per menit. Penyebab xerostomia meliputi radioterapi, penyakit sistemik seperti diabetes, sialadenitis kronis, sialoadenoma, serta efek samping dari sekitar 400 obat yang umum digunakan. Faktor lain termasuk dehidrasi, masalah hormonal, dan atrofi fisiologis pada sel seiring bertambahnya usia.

4. Keausan gigi

Kehilangan enamel gigi pada orang dewasa tua umum terjadi, khususnya jika ada kehilangan gigi sebagian. Keausan gigi, yang meliputi atrisi, erosi, abrasi, dan abfraksi, seringkali tidak memerlukan intervensi restoratif jika tidak menimbulkan rasa sakit, masalah penampilan, sensitivitas, atau kesulitan fungsi.

Hilangnya enamel gigi disebabkan oleh:

- a. Atrisi, yang disebabkan oleh kontak gigi ke gigi.
- b. Erosi, yang disebabkan oleh serangan asam non-bakteri pada gigi, yaitu bukan karena karies.
- c. Abrasi, yang disebabkan oleh keausan akibat kontak fisik dengan agen selain gigi (misalnya menyikat gigi).

d. Abfraksi, hilangnya permukaan gigi servikal yang diduga disebabkan oleh fleksur kuspis.

Penyebab keausan biasanya multifaktorial, memerlukan evaluasi untuk menentukan tingkat kerusakan serta penyebabnya. Dalam kasus atrisi, pelindung gigi oklusal dapat dianjurkan. Erosi memerlukan analisis pola makan, sedangkan abrasi mungkin membutuhkan perubahan kebiasaan. Restorasi dipertimbangkan untuk sensitivitas, masalah estetika, atau mencegah kerusakan lebih lanjut.

5. Kehilangan gigi

Selama beberapa tahun terakhir, terlihat penurunan signifikan dalam kasus orang dewasa berusia 65 tahun ke atas yang mengalami kehilangan semua gigi. Ada perubahan pada struktur anatomi akibat pencabutan gigi, yang dapat terjadi baik di dalam mulut maupun di luar mulut. Perubahan ini bervariasi antara individu yang sepenuhnya kehilangan gigi dan mereka yang masih memiliki sebagian. Dengan bertambahnya usia, hilangnya tulang alveolar menjadi hal yang tak terhindarkan, namun tingkat kehilangan ini lebih tinggi pada orang yang sepenuhnya edentulous. Di samping perubahan anatomi itu, terdapat kemungkinan masalah lain yang muncul akibat hilangnya gigi. Ini meliputi:

a. Masalah berbicara:

Kehilangan gigi depan yang tidak diatasi dengan gigi palsu, jembatan gigi, atau implan dapat memengaruhi kemampuan berbicara secara negatif.

- b. Masalah dalam mengunyah:
efektivitas dalam mengunyah mungkin berkurang.
- c. Penampilan:
selain menjaga keberadaan tulang, hilangnya gigi juga menyebabkan hilangnya dukungan untuk jaringan lunak, yang dapat berakibat pada perubahan pada penampilan wajah.

6. Lansia dan Kesehatan Gigi

Kini ada harapan bahwa sebagian besar orang akan mempertahankan gigi mereka sepanjang hidupnya. Namun, harapan ini pada lansia membawa tantangan spesifik bagi praktisi kesehatan dalam usaha menjaga atau meningkatkan kesehatan mulut. Secara umum, terdapat beberapa factor yang menjadi tantangan terhadap perawatan gigi yang akan diberikan pada lansia karena berbagai kondisi fisiologis dan patologis yang telah dibahas sebelumnya, factor tersebut meliputi:

- a. Penurunan keterampilan manual:
Kehilangan keterampilan secara keseluruhan, seperti yang terlihat pada kondisi seperti arthritis, dapat membuat perawatan kebersihan mulut menjadi menantang dan memakan waktu. Ini perlu dipertimbangkan ketika menetapkan target perawatan yang realistis.
- b. Pengurangan mobilitas:
Selain memastikan akses yang tepat, seperti aksesibilitas untuk kursi roda, seringkali dianjurkan

untuk memberikan tambahan waktu untuk pertemuan.

c. Gangguan penglihatan:

Ini harus diperhatikan baik dalam konteks menjaga kebersihan mulut maupun dalam penyampaian informasi tertulis.

d. Dentin gigi yang telah diperbaiki secara signifikan:

Kontur yang tidak rata dan potensi untuk abrasi dapat mendorong akumulasi plak dan menyulitkan proses pembersihan.

e. Gigi yang tidak rata atau tidak sejajar:

Hal ini membuat perawatan menjadi lebih sulit.

f. Permukaan akar yang terekspos:

Ini menciptakan area yang lebih luas pada gigi untuk diurus.

g. Kesulitan dalam berkomunikasi:

Ini bisa diakibatkan oleh penurunan kemampuan mendengar atau masalah dalam pemahaman.

D. Cara Merawat Gigi dan Mulut pada Lansia

1. Teknik Menyikat Gigi yang Benar untuk Lansia

Kesehatan mulut yang baik dapat dipertahankan dengan sedikit ketidaknyamanan bagi pasien, menggunakan sikat gigi kecil. Apabila menyikat gigi tidak dapat dilakukan, lapisan dalam mulut dan lidah dapat dibersihkan menggunakan jari yang dilapisi sarung tangan dan kain kasa. Pada lansia dengan keterbatasan gerakan motorik dapat menggunakan sikat gigi elektrik,

sikat ini jika digunakan dengan benar, dapat menghilangkan plak secara efektif. Lansia dapat melakukan teknik menyikat gigi yang benar dengan menggunakan sikat berbulu lembut dan pasta gigi berfluoride.

Teknik menyikat gigi yang benar dapat mencegah masalah gigi dan gusi, seperti gigi berlubang dan penyakit periodontal. Berikut langkah-langkah yang direkomendasikan:

- a. Pilih waktu yang tepat
 - 1) Sikat gigi setidaknya dua kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur.
 - 2) Jika memungkinkan, bersihkan gigi setelah mengonsumsi makanan manis atau asam untuk mencegah kerusakan gigi.
- b. Gunakan pasta gigi berfluoride

Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk membantu mencegah kerusakan gigi dan memperkuat enamel.
- c. Posisi sikat gigi
 - 1) Pegang sikat gigi dengan sudut 45 derajat terhadap garis gusi.
 - 2) Lakukan gerakan memutar kecil dengan tekanan lembut, fokus pada setiap bagian gigi secara perlahan.
- d. Bersihkan seluruh permukaan gigi
 - 1) Bersihkan bagian depan, belakang, dan permukaan gigi untuk mengunyah.

- 2) Jangan lupa membersihkan area gigi yang sulit dijangkau, seperti bagian belakang gigi geraham.
- e. Perhatikan area gusi
Gosok perlahan di sekitar garis gusi untuk mencegah penumpukan plak tanpa melukai jaringan gusi.
- f. Durasi menyikat
 - 1) Sikat gigi selama 2–3 menit untuk memastikan semua bagian gigi dan mulut bersih.
 - 2) Gunakan timer atau lagu pendek sebagai panduan durasi.
- g. Kumur dengan air secukupnya
Hindari membilas mulut terlalu banyak agar fluoride dari pasta gigi tetap bekerja melindungi gigi.

Pemilihan Sikat Gigi yang Sesuai untuk Lansia

Memilih sikat gigi yang tepat sangat penting bagi lansia untuk memastikan kenyamanan dan efektivitas dalam membersihkan gigi. Berikut adalah tips pemilihannya:

- a. Pilih bulu sikat yang lembut (soft-bristle)
 - 1) Sikat gigi dengan bulu yang lembut dapat membersihkan gigi dan gusi dengan baik tanpa menyebabkan iritasi atau melukai gusi.
 - 2) Bulu sikat yang terlalu keras dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan resesi gusi.
- b. Kepala sikat yang kecil
Kepala sikat yang kecil lebih mudah menjangkau area sulit di dalam mulut, terutama untuk lansia dengan keterbatasan gerak atau gigi yang tidak rata.

- c. Pegangan sikat yang nyaman
 - 1) Pilih sikat gigi dengan pegangan yang ergonomis dan anti-selip, sehingga mudah dipegang meski dengan kekuatan tangan yang berkurang.
 - 2) Untuk lansia dengan keterbatasan motorik, sikat gigi dengan gagang yang lebih besar atau tambahan bantalan bisa menjadi solusi.
- d. Pertimbangkan sikat gigi elektrik
 - 1) Sikat gigi elektrik dapat membantu lansia yang memiliki kesulitan menyikat dengan gerakan manual.
 - 2) Pilih sikat gigi elektrik dengan mode lembut (gentle mode) untuk menghindari tekanan berlebihan pada gigi dan gusi.
- e. Konsultasikan dengan dokter gigi

Jika ragu, lansia disarankan berkonsultasi dengan dokter gigi untuk mendapatkan rekomendasi sikat gigi yang sesuai dengan kondisi gigi dan gusi mereka.

Dengan menyikat gigi menggunakan teknik yang benar dan memilih sikat gigi yang tepat, lansia dapat menjaga kesehatan gigi dan gusi dengan optimal. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar kesehatan mulut tetap terpantau dengan baik.

2. Penggunaan benang gigi

Penggunaan benang gigi memerlukan lebih banyak keterampilan dan lebih memakan waktu daripada

tusuk gigi, tetapi dapat membersihkan plak pada permukaan proksimal gigi dengan efektif.

E. Penggunaan Gigi Tiruan pada Lansia

Perawatan dan pembersihan gigi palsu lepasan sangat penting untuk menjaga kesehatan mulut, mencegah bau, dan menghindari infeksi pada gusi.

1. Membersihkan Gigi Tiruan Secara Rutin

- a. Bersihkan setelah makan
 - 1) Lepaskan gigi tiruan dan cuci dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa makanan.
 - 2) Jangan bilas dengan air panas, karena dapat merusak bentuk gigi tiruan.
- b. Gunakan sikat khusus gigi tiruan
 - 1) Gunakan sikat yang memiliki bulu lembut atau sikat yang dirancang khusus untuk gigi tiruan agar tidak menimbulkan goresan.
 - 2) Hindari penggunaan sikat gigi dengan bulu kasar yang bisa merusak permukaan gigi tiruan.
- c. Pilih pembersih yang tepat
 - 1) Gunakan sabun lembut atau pembersih khusus untuk gigi tiruan, jangan menggunakan pasta gigi biasa karena dapat bersifat abrasif.
 - 2) Hindari bahan kimia yang keras, seperti pemutih, yang dapat merusak warna dan struktur gigi tiruan.
- d. Bersihkan semua bagian gigi tiruan

Sikat dengan menyeluruh, termasuk bagian dalam, luar, dan permukaan yang bersentuhan dengan gusi.

2. Menjaga Kebersihan Mulut dan Gusi

- a. Bersihkan gusi dan lidah setelah melepas gigi palsu
 - 1) Pakai sikat gigi dengan bulu lembut atau kain basah untuk membersihkan gusi, lidah, dan langit-langit mulut.
 - 2) Tindakan ini bermanfaat dalam mencegah infeksi serta mendukung aliran darah di gusi.
- b. Gunakan obat kumur dengan sifat antiseptik
Ini membantu untuk membunuh kuman dan menyegarkan nafas.

3. Perawatan Gigi Tiruan saat Tidak Dipakai

- a. Rendam gigi tiruan dalam air atau cairan khusus
 - 1) Pilih air bersih atau larutan khusus untuk merendam gigi tiruan agar tidak kering dan kehilangan bentuk.
 - 2) Hindari merendam gigi tiruan dalam air panas agar tidak terjadi pelengkungan.
- b. Jangan biarkan gigi tiruan menjadi kering
Gigi tiruan yang tidak lembap dapat menjadi rapuh dan mudah pecah.
- c. Simpan di tempat yang aman
Taruhkan di wadah tertutup yang berisi air bersih ketika tidak digunakan.

4. Periksa dan Ganti Gigi Tiruan Secara Berkala

- a. Kunjungi dokter gigi secara rutin
 - 1) Periksa kondisi gigi tiruan setiap 6 bulan hingga 1 tahun untuk memastikan tetap nyaman digunakan.

- 2) Jika ada kelonggaran atau ketidaknyamanan, segera konsultasikan ke dokter gigi.
- b. Ganti gigi tiruan jika sudah tidak layak
Jika gigi tiruan mulai longgar, retak, atau berubah bentuk, segera ganti agar tidak menyebabkan iritasi gusi atau gangguan fungsi kunyah.

5. Hindari Kebiasaan yang Merusak Gigi Tiruan

- a. Jangan menggigit makanan terlalu keras
- b. Jangan menggunakan gigi tiruan untuk membuka kemasan atau menggigit benda keras
- c. Jangan tidur dengan gigi tiruan kecuali atas anjuran dokter

F. Penyuluhan Kesehatan Gigi untuk Lansia

Strategi efektif dalam memberikan edukasi kesehatan gigi kepada lansia

1. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisiologis normal yang terlihat selama penuaan dan perubahan patologis.
2. Komunikasikan filosofi perawatan kesehatan untuk memaksimalkan Kesehatan dalam menghadapi kondisi kronis.
3. Memilih dan menjelaskan strategi promosi kesehatan berdasarkan kebutuhan lansia.
4. Mendorong kepatuhan terhadap semua pengobatan dan aturan medis.
5. Menghubungkan status kesehatan klien dengan modifikasi yang diperlukan untuk perawatan kebersihan gigi.

6. Menyesuaikan instruksi kebersihan mulut dengan keterbatasan fungsional dan kondisi kesehatan mulut.
7. Menjelaskan perkembangan dan pencegahan karies gigi dan penyakit periodontal.
8. Memberikan konseling gizi mengenai pengurangan karbohidrat olahan, pembatasan ngemil kariogenik, dan kecukupan asupan makanan.
9. Merekomendasikan penggunaan fluorida topikal dan profesional untuk mencegah kerusakan gigi.
10. Merekomendasikan penggunaan produk kebersihan mulut dan agen kemoterapi oleh klien untuk mencegah dan mengendalikan penyakit periodontal.
11. Membantu upaya penghentian tembakau.
12. Menjelaskan pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker mulut.
13. Memberikan edukasi mengenai perubahan akibat obat pada rongga mulut.
14. Menjelaskan metode untuk mengidentifikasi dan mengelola xerostomia.
15. Memberikan instruksi kepada pengasuh keluarga mengenai penilaian mulut yang tepat dan perawatan kebersihan mulut.

G. Beberapa Materi Yang Relevan Sehingga Perlu Disampaikan Dalam Penyuluhan Kesehatan Gigi Untuk Lansia

1. Pentingnya Kesehatan Gigi dan Mulut pada Lansia

- a. Hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
- b. Dampak kesehatan gigi yang buruk pada lansia, seperti gangguan mengunyah, bicara, dan pencernaan.

2. Perubahan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Lansia

- a. Penurunan produksi air liur (mulut kering atau xerostomia) dan penyebabnya.
- b. Penyakit periodontal (gusi) dan risiko kehilangan gigi.
- c. Resorpsi tulang rahang setelah kehilangan gigi.
- d. Gigi aus, retak, atau perubahan warna gigi seiring bertambahnya usia.

3. Penyakit Gigi dan Mulut yang Sering Terjadi pada Lansia

- a. Karies gigi: Terutama karies akar akibat penurunan gusi.
- b. Penyakit gusi (periodontitis): Gejala, penyebab, dan pencegahannya.
- c. Xerostomia: Dampak mulut kering pada gigi dan cara mengatasinya.
- d. Kandidiasis oral: Infeksi jamur pada mulut yang sering terjadi akibat pemakaian gigi tiruan atau kondisi mulut yang tidak bersih.
- e. Kanker mulut: Faktor risiko (merokok, alkohol, dan iritasi kronis) dan pentingnya deteksi dini.

4. Cara Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut

- a. Teknik menyikat gigi yang benar dan pemilihan sikat gigi yang sesuai untuk lansia.

- b. Pentingnya menggunakan pasta gigi berfluoride.
- c. Pemakaian benang gigi dan alat bantu lainnya untuk membersihkan sela-sela gigi.
- d. Perawatan gigi tiruan: cara membersihkan, menyimpan, dan memastikan gigi tiruan tetap nyaman dipakai.
- e. Pentingnya menjaga kebersihan lidah dan mulut.

5. Pola Makan yang Mendukung Kesehatan Gigi dan Mulut

- a. Menghindari makanan dan minuman manis yang dapat menyebabkan karies.
- b. Konsumsi makanan yang tinggi serat untuk membantu membersihkan gigi dan merangsang produksi air liur.
- c. Pentingnya menjaga hidrasi untuk mengatasi mulut kering.
- d. Asupan kalsium dan vitamin D untuk kesehatan gigi dan tulang rahang.

6. Pemeriksaan Rutin ke Tenaga Kesehatan Gigi

- a. Pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala minimal 6 bulan sekali.
- b. Peran tenaga kesehatan gigi dalam deteksi dini penyakit gigi dan mulut.
- c. Pemeliharaan dan perawatan gigi tiruan atau implan gigi.

7. Praktik Pencegahan di Rumah

- a. Rutin berkumur dengan air garam hangat atau obat kumur antiseptik yang direkomendasikan.

- b. Cara melakukan pemeriksaan mandiri kesehatan mulut (deteksi bengkok, sariawan yang tak kunjung sembuh, atau perubahan jaringan).

H. Peran tenaga Kesehatan gigi dalam peningkatan kesehatan gigi lansia

Kegiatan yang bisa dilakukan oleh tenaga terapis gigi adalah dalam menangani lansia yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah adalah :

1. Memberikan perawatan gigi saat klien dibawa ke klinik gigi
2. Memberikan program pendidikan dalam jabatan bagi staf dan/atau anggota keluarga
3. Menandai gigi palsu untuk identifikasi
4. Memberikan aplikasi fluoride
5. Mengembangkan rencana perawatan individual
6. Memodifikasi alat bantu higienis mulut

I. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Lansia adalah kelompok yang heterogen, dan terdapat variabilitas yang luar biasa dalam masalah fisik, psikososial, dan lingkungan dalam kelompok usia ini. Usia fungsional, bukan usia kronologis, adalah ukuran terbaik untuk digunakan saat memberikan perawatan kepada orang dewasa yang lebih tua.
2. Populasi lansia menjadi lebih beragam secara ras dan etnis. Jumlah wanita lanjut usia lebih banyak daripada pria lanjut usia. Lansia terkonsentrasi di negara bagian

tertentu dan tidak terdistribusi secara merata dalam populasi.

3. Seiring bertambahnya usia, hampir semua sistem tubuh menunjukkan perubahan fisik yang normal. Perubahan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan dampak penyakit; meskipun demikian, membedakan antara penuaan yang wajar dan kondisi penyakit sering kali menjadi tantangan.
4. Sebagian besar lansia menderita setidaknya satu penyakit kronis, dengan yang paling umum meliputi artritis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, kanker, diabetes, serta stroke.
5. Tingkat kejadian karies pada gigi koronal dan akar lebih tinggi pada lansia dibandingkan dengan kelompok dewasa muda; meskipun begitu, diperkirakan sekitar 15% orang tua mengalami kehilangan semua gigi, dengan proyeksi penurunan yang diharapkan di masa depan.
6. Rencana pencegahan dan pengelolaan karies pada orang tua perlu menekankan pentingnya membersihkan plak setiap hari, membatasi konsumsi karbohidrat olahan, dan mengaplikasikan fluorida topikal, pengganti air liur, serta produk calcium dan fosfat setiap hari, terutama saat mengalami mulut kering.
7. Sebagian kecil namun signifikan dari lansia mengalami periodontitis yang parah, di mana terdapat tingkat kehilangan perlekatan yang lebih tinggi serta prevalensi gingivitis di kalangan lansia.

8. Upaya dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit periodontal harus melibatkan pembersihan plak secara teratur, penggunaan agen kemoterapi, serta frekuensi kunjungan yang lebih tinggi untuk pembersihan dan pemeriksaan profesional.
9. Para profesional kesehatan gigi dapat berkolaborasi dengan staf perawat di ruangan rawat inap, berkoordinasi dengan pengasuh/caregiver serta membantu individu lansia di rumah, dalam berbagai kapasitas untuk meningkatkan kesehatan gigi mereka.

J. Referensi

- Darby, M. L. (2011). *Mosby's Comprehensive Review of Dental Hygiene-E-Book*.
- Hasibuan WW, Putranti DT. The Correlation Between Partial Tooth Loss Towards Nutritional Status and Quality of Life at UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai in 2020. *Cakradonya Dent J*.2020;13(1):72-80.
- Husmiati, Irmayani, Noviana I, Amalia Ad. Kualitas Hidup Lanjut Usia di Daerah Rawan Bencana (Studi Kasus di Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan). *Sosio Konsepsia*. 2016; 5(02):34-44.
- Korah SC, Pangemanan DHC, Wowor VNS. Kualitas Hidup Lansia Pengguna dan Bukan Pengguna Gigi Tiruan. *e-GiGi*. 2020;8(2):66-72.
- Marya, C. M. (2011). *A textbook of public health dentistry*. JP Medical Ltd.
- Noble, S. (Ed.). (2012). *Clinical textbook of dental hygiene and therapy*. John Wiley & Sons.

- Putri, M. H., Herijulianti, E., & Nurjannah, N. (2010). Ilmu pencegahan penyakit jaringan keras dan jaringan pendukung gigi. *Jakarta: EGC, 25*.
- Rohmah AIN, Purwaningsih, Bariyah K. Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Keperawatan*. 2012;3(2):120-132.
- Walsh, M., & Darby, M. L. (2014). *Dental Hygiene-E-Book: Theory and Practice*. Elsevier Health Sciences.

CHAPTER 3

PENYULUHAN KESEHATAN GIGI UNTUK ANAK-ANAK DAN REMAJA

Drg. Arnetty, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan gigi merupakan bagian integral dari kesehatan anak dan remaja secara keseluruhan. Penyuluhan kesehatan gigi untuk anak-anak dan remaja bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan mulut dan mencegah masalah gigi. Penyuluhan kesehatan gigi untuk remaja adalah suatu upaya penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Remaja berada pada fase transisi di mana kebiasaan kesehatan yang dibentuk dapat berdampak jangka panjang. Kesehatan gigi yang baik tidak hanya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk makan dan berbicara, tetapi juga berdampak pada kesehatan keseluruhan dan kepercayaan diri (ADA 2018), Masalah kesehatan gigi dapat menyebabkan rasa sakit, infeksi, dan bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Masalah gigi yang tidak ditangani dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja, baik dalam hal akademik maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa "anak-anak dengan masalah gigi cenderung memiliki penurunan

performa akademis karena rasa sakit dan ketidaknyamanan (Moursi et al., 2014).

Kesehatan gigi yang baik pada anak-anak sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup mereka. Menurut American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD 2021), Kesehatan gigi yang buruk dapat menyebabkan rasa sakit, infeksi, dan kesulitan dalam makan, berbicara, dan belajar. Bagi remaja, tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga untuk kesehatan mental dan emosional. Kesehatan gigi yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan diri remaja dan menyebabkan masalah sosial serta psikologis (American Dental Association, 2020).

Karies gigi adalah salah satu penyakit gigi paling umum yang dialami oleh anak-anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 20% anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun mengalami setidaknya satu gigi yang berlubang (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Sedangkan remaja sering kali menghadapi berbagai masalah kesehatan gigi, termasuk karies, gingivitis, dan masalah ortodontik. Karies gigi adalah masalah kesehatan yang paling umum pada remaja, dengan prevalensi yang signifikan di kalangan kelompok usia ini (Moursi et al., 2014). Pada masa remaja, individu mulai mengambil alih tanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Remaja yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan gigi cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan mulut mereka (Kumar et al., 2016). Diet yang tidak sehat dan

kebiasaan makan yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan gigi remaja. Konsumsi makanan tinggi gula berkontribusi pada peningkatan risiko karies di kalangan remaja (Burt & Pai, 2001).

Edukasi mengenai pilihan makanan sehat sangat penting dalam penyuluhan kesehatan gigi. Masalah gigi yang tidak ditangani dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja, baik dalam hal akademik maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan masalah gigi cenderung memiliki penurunan performa akademis karena rasa sakit dan ketidaknyamanan" (Moursi et al., 2014).

Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan kesehatan gigi yang baik pada anak-anak. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak-anak yang didorong oleh orang tua untuk menjaga kebersihan gigi cenderung memiliki kesehatan gigi yang lebih baik (Kumar et al., 2016). Penyuluhan kepada orang tua juga penting agar mereka dapat memberikan dukungan yang tepat. Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk melakukan penyuluhan kesehatan gigi. Menurut penelitian, program penyuluhan di sekolah dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik kebersihan gigi di kalangan anak-anak (Goyal et al., 2015). Dengan melibatkan sekolah, informasi dapat disampaikan secara efektif kepada anak-anak.

Di era digital, media dan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan penyuluhan kesehatan gigi.

Penggunaan aplikasi dan konten interaktif dapat membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar tentang kesehatan gigi (Hassan et al., 2020). Ini menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi. Media sosial dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kesehatan gigi kepada remaja. Platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan yang relevan dan menarik bagi remaja (Hassan et al., 2020). Dengan pendekatan yang menarik, remaja lebih mungkin terlibat dan menyerap informasi.

B. Struktur Gigi

Gigi adalah bagian penting dari sistem pencernaan dan kesehatan mulut manusia. Mereka berfungsi tidak hanya untuk mengunyah makanan, tetapi juga berperan dalam estetika wajah dan berbicara. Gigi terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk enamel, dentin, pulpa, dan sementum.

1. Enamel adalah lapisan terluar yang melindungi gigi dari kerusakan. Enamel adalah bahan keras yang terdiri dari mineral, terutama hidroksiapatit. Enamel adalah substansi paling keras di tubuh manusia dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap asam (Ten Cate, 2008).
2. Dentin Terletak di bawah enamel, dentin adalah jaringan yang lebih lunak dan memberikan dukungan struktural. Dentin mengandung tubulus mikroskopis yang berfungsi

sebagai saluran untuk pengiriman sinyal ke saraf di pulpa" (Buchalla & Attin, 2007).

3. Pulpa Ini adalah bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Pulpa berfungsi untuk memberikan nutrisi dan sensitivitas pada gigi, serta membantu dalam pertumbuhan gigi (Scully, 2013).
4. Sementum adalah lapisan yang menutupi akar gigi dan membantu mengikat gigi ke jaringan tulang rahang. Sementum memiliki peran penting dalam mempertahankan posisi gigi dalam soketnya (Rudolph et al., 2010).



Gambar 3.1 Penampang Gigi

Sumber: Iwak PITHIK

Ada empat jenis gigi dalam mulut manusia, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda:

1. Gigi Insisivus atau gigi seri terletak di depan yang digunakan untuk memotong makanan, memiliki bentuk yang datar dan tajam, (Kumar et al., 2016). Gigi seri berjumlah 8 gigi di depan mulut, yang terdiri dari 4 gigi

di atas dan 4 gigi di bawah. Jenis gigi ini bertugas untuk mengigit, memotong, merobek, dan menahan makanan saat Anda mengunyah. Kemunculan gigi seri merupakan awal pertumbuhan gigi pada anak yang umumnya terjadi saat bayi berusia 8-16 bulan. Sedangkan untuk gigi seri permanen muncul umur 6-9 tahun. (Aji Satria 2024)

2. Gigi Kaninus atau gigi taring berada pada kedua sisi gigi seri. Pada anatomi gigi, ini merupakan jenis gigi paling tajam yang digunakan untuk merobek atau mengoyak makanan. Gigi taring susu muncul pada usia 9-16 bulan pada anak. Sementara itu, gigi taring permanen baru akan muncul di sekitar usia 9-12 tahun. (Aji Satria 2024)
3. Gigi Premolar atau geraham kecil yang terletak di belakang gigi taring. Gigi premolar memiliki dua cusps dan berperan penting dalam proses pengunyahan" (Kumar et al., 2016). Gigi premolar digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa memiliki 8 gigi premolar di setiap sisi mulut, terdiri dari 4 gigi di rahang atas dan 4 gigi di rahang bawah. Premolar pertama muncul sekitar usia 10-12 tahun dengan premolar kedua muncul sekitar setahun kemudian. Jenis gigi ini terletak di antara gigi taring dan gigi geraham. Premolar dan molar mempunyai serangkaian elevasi (titik atau puncak) yang digunakan untuk memecah dan menghancurkan partikel makanan (Aji Satria 2024)

4. Gigi Molar atau gigi geraham besar belakang memiliki permukaan yang lebih luas dan datar untuk menghancurkan makanan (Kumar et al., 2016). Gigi geraham juga digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jenis gigi ini memiliki struktur pipih yang terletak pada bagian belakang mulut. Berjumlah 8 gigi geraham, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah, gigi geraham susu muncul antara usia 13-33 bulan. Geraham pertama permanen muncul pada usia 6-7 tahun sedangkan geraham kedua 11-13 tahun.(Aji Satria 2024)
5. Gigi geraham bungsu
Gigi geraham bungsu adalah gigi yang paling akhir muncul dan terletak di paling belakang gigi geraham. Biasanya, gigi ini belum akan muncul hingga usia 17–21 tahun. Akan tetapi, sekitar 5–37% populasi umum mungkin tidak mempunyai gigi bungsu sama sekali. Pertumbuhan gigi bungsu terkadang mendesak gigi lainnya. Hal ini berisiko menimbulkan nyeri dan infeksi sehingga gigi bungsu harus segera dicabut.

Waktu Tumbuh (thn)	7-8	8-9	11-12	10-11	10-12	6-7	12-13	17-21
Gigi Tetap Atas								
Waktu Tumbuh (thn)	6-7	7-8	10-12	9-11	10-12			
Waktu Tumbuh (bln)	8-12	9-13	16-22	13-19	25-33			
Gigi Susu Atas								
Gigi Susu Bawah								
Waktu Tumbuh (bln)	6-10	10-16	17-23	14-18	23-31			
Waktu Tumbuh (thn)	6-7	7-8	9-12	9-11	10-12			
Gigi Tetap Bawah								
Waktu Tumbuh (thn)	6-7	7-8	9-10	10-12	11-12	6-7	11-13	17-21

Gambar 3.2 Tabel Erupsi Gigi
Sumber: Go dok. Indonesia

C. Fungsi Gigi

Gigi memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan individu:

1. Mengunyah makanan

Fungsi utama gigi adalah untuk memecah dan mengunyah makanan serta dapat mempermudah proses pencernaan. Proses mengunyah yang efektif sangat penting untuk pencernaan yang baik (Harrison et al., 2015).

2. Berbicara

Gigi juga berperan dalam produksi suara dan ucapan yang jelas. Kehadiran gigi yang lengkap

membantu dalam pembentukan suara dan pengucapan kata (Scully, 2013).

3. Estetika

Gigi yang sehat berkontribusi pada penampilan wajah dan kepercayaan diri. Kesehatan gigi yang baik sangat penting untuk menjaga estetika wajah dan meningkatkan kepercayaan diri (O'Connell et al., 2015).

D. Masalah Kesehatan Gigi Anak-anak dan Remaja

1. Karies Gigi

Karies gigi adalah masalah kesehatan gigi yang paling umum dialami oleh anak-anak dan remaja. Sekitar 20% anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun mengalami setidaknya satu gigi yang berlubang (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Karies gigi adalah kerusakan permanen pada permukaan gigi yang disebabkan oleh proses demineralisasi akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri dari sisa makanan, terutama yang mengandung gula. Karies merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan kerusakan jaringan keras gigi (Jiang et al., 2019). Penyebab utama karies gigi meliputi kebersihan mulut yang buruk, konsumsi makanan dan minuman manis, serta kurangnya fluor. Bakteri yang ada di dalam mulut memecah karbohidrat menjadi asam, yang dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan karies (Marsh, 2010). Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya karies gigi termasuk usia, diet, dan kondisi kesehatan tertentu. Anak-anak dan

remaja lebih rentan terhadap karies karena pola makan yang tinggi gula dan kebersihan mulut yang tidak memadai (Petersen, 2003). Selain itu, kondisi medis seperti xerostomia juga dapat meningkatkan risiko.

2. Gingivitis (Radang Gusi)

Gingivitis adalah tahap awal dari penyakit gusi yang ditandai oleh peradangan gusi. Gejalanya meliputi kemerahan, pembengkakan, dan perdarahan saat menyikat gigi. Gingivitis dapat disebabkan oleh penumpukan plak di gigi, yang mengiritasi gusi (Sanz et al., 2018). Penyebab utama gingivitis adalah kebersihan mulut yang buruk dan penumpukan plak. Plak adalah lapisan bakteri yang terbentuk di gigi dan dapat mengeras menjadi tartar jika tidak dihilangkan (Petersen & Ogawa, 2012). Jika gingivitis tidak dirawat dapat menyebabkan periodontitis adalah di mana peradangan telah menyebar ke jaringan yang lebih dalam, termasuk tulang yang mendukung gigi. Periodontitis dapat menyebabkan kehilangan gigi jika tidak diobati (Page & Kornman, 1997). Gejala periodontitis meliputi gusi yang berdarah, bau mulut yang persisten, gusi yang menyusut, dan gigi yang longgar. Gejala ini muncul karena adanya infeksi yang lebih dalam dan kerusakan pada jaringan pendukung (Sanz et al., 2018). Remaja lebih rentan terhadap gingivitis karena perubahan hormonal yang mempengaruhi kesehatan gusi (Petersen Ogawa, 2012).

3. Maloklusi (Gigi Berjejal)

Maloklusi adalah ketidakaturan posisi gigi dan hubungan antara rahang atas dan rahang bawah. Maloklusi dapat didefinisikan sebagai deviasi dari hubungan normal antara gigi-gigi yang berfungsi dalam konteks yang lebih luas dari rahang (Bishara, 1998). Beberapa faktor dapat menyebabkan maloklusi, Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan maloklusi, termasuk ukuran rahang dan posisi gigi (Jensen et al., 2004). Kebiasaan seperti mengisap jari atau penggunaan dot yang berkepanjangan dapat mempengaruhi perkembangan gigi dan rahang. Kebiasaan buruk ini dapat mengganggu pertumbuhan gigi permanen (Moyers, 1988). Beberapa kondisi medis, seperti adenoid hipertrofi, dapat mempengaruhi perkembangan gigi dan rahang (Petersen et al., 2005). Maloklusi dapat memiliki berbagai dampak pada kesehatan gigi dan kualitas hidup, termasuk menyebabkan kesulitan dalam mengunyah makanan dan dapat mempengaruhi cara berbicara. Anak-anak dengan maloklusi mungkin mengalami kesulitan dalam pengucapan kata-kata tertentu (Kohler et al., 2009). Maloklusi dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mulut, seperti gigi berlubang dan penyakit gusi. Gigi yang tidak sejajar lebih sulit dibersihkan, meningkatkan risiko penumpukan plak (López et al., 2015). Dampak psikologis Penampilan gigi yang tidak rata dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental

anak. Anak-anak dengan maloklusi mungkin mengalami stigma sosial atau rasa percaya diri yang rendah (Kumar et al., 2016). Sekitar 60-70% remaja mengalami beberapa bentuk maloklusi yang dapat memengaruhi fungsi mengunyah dan penampilan (Bishara, 2001). Maloklusi sering kali memerlukan perawatan ortodontik seperti kawat gigi.

4. Kebersihan Mulut

Kebersihan mulut yang buruk adalah faktor penyebab utama berbagai masalah kesehatan gigi. Anak-anak dan remaja yang tidak memiliki kebiasaan menyikat gigi yang baik lebih rentan terhadap karies dan penyakit gusi (Niemann et al., 2017). Pendidikan tentang pentingnya kebersihan mulut sangat penting untuk pencegahan.

5. Pengaruh Diet Tidak Sehat

Diet yang tinggi gula dan makanan olahan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan gigi. Konsumsi makanan dan minuman manis yang berlebihan berhubungan langsung dengan peningkatan risiko karies di kalangan anak-anak dan remaja (Moynihan & Kelly, 2014). Edukasi mengenai pola makan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi.

E. Faktor Penyebab Masalah Kesehatan Gigi

1. Pola makan yang tidak sehat

Merupakan salah satu faktor penyebab utama masalah kesehatan gigi pada anak dan remaja.

Konsumsi gula yang tinggi salah satu aspek utama dari pola makan yang tidak sehat adalah. Gula merupakan makanan utama bagi bakteri penyebab kerusakan gigi. Konsumsi minuman manis dapat mengurangi asupan air yang cukup, yang penting untuk menjaga kesehatan mulut (Harris et al., 2009). Dehidrasi dapat menyebabkan mulut kering, yang meningkatkan risiko masalah gigi. Konsumsi tinggi makanan dan minuman manis dapat meningkatkan risiko terjadinya karies gigi pada anak-anak (Marinho et al., 2003).

Makanan olahan dan junk food sering kali mengandung gula tambahan dan lemak tidak sehat. Makanan ini tidak hanya rendah nutrisi tetapi juga dapat berkontribusi pada masalah kesehatan gigi, seperti gigi berlubang dan penyakit gusi" (Nishida & Hara, 2014). Kebiasaan makan yang buruk, seperti ngemil terus-menerus atau makan sebelum tidur, dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi. Kebiasaan makan yang buruk dapat menyebabkan penumpukan plak dan asam yang merusak enamel gigi (Rugg-Gunn, 2001). Pola makan yang tidak sehat sering kali tidak mencakup makanan bergizi yang penting untuk kesehatan gigi, seperti buah-buahan, sayuran, dan produk susu. Nutrisi yang baik, termasuk kalsium dan vitamin D, penting untuk perkembangan gigi yang sehat (Dawes, 2004).

Pola makan yang tidak sehat, yang ditandai dengan konsumsi gula yang tinggi, makanan olahan, kebiasaan makan yang buruk, rendahnya asupan nutrisi

penting, dan konsumsi minuman manis, berkontribusi besar terhadap masalah kesehatan gigi pada anak dan remaja. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi anak-anak dan remaja tentang pentingnya pola makan sehat untuk menjaga kesehatan gigi mereka.

2. Kurangnya Kebiasaan Menjaga Kebersihan

Menjaga kebersihan gigi sangat penting untuk mencegah masalah gigi dan mulut, seperti karies dan penyakit gusi. Kebersihan gigi yang baik dapat mencegah timbulnya masalah gigi dan meningkatkan kesehatan mulut secara keseluruhan (Suryani et al., 2019). Banyak anak dan remaja yang kurang memiliki pengetahuan mengenai cara menjaga kebersihan gigi yang efektif. Kurangnya pengetahuan tentang teknik menyikat gigi yang benar berkontribusi pada tingginya prevalensi karies di kalangan anak-anak (Pratiwi et al., 2020). Kebiasaan menyikat gigi yang tidak teratur adalah salah satu faktor penyebab utama masalah gigi. Hanya sedikit anak yang menyikat gigi dua kali sehari, yang merupakan standar yang disarankan oleh para ahli kesehatan gigi (Widyastuti et al., 2018).

Lingkungan dan kebiasaan keluarga juga mempengaruhi perilaku menjaga kebersihan gigi anak. Anak-anak yang lahir dari keluarga dengan kebiasaan menjaga kebersihan gigi yang baik cenderung lebih disiplin dalam merawat gigi mereka (Marlina & Amalia, 2021).

Akses terhadap layanan kesehatan gigi dan perawatan gigi yang memadai dapat mempengaruhi kebiasaan menjaga kebersihan gigi. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan gigi di wilayah pedesaan sering kali mengakibatkan rendahnya tingkat perawatan gigi di kalangan anak-anak (Hidayati et al., 2020).

3. Pengaruh Gaya Hidup dan Kebiasaan Buruk

Kebiasaan merokok, meskipun lebih umum di kalangan remaja, dapat berdampak negatif pada kesehatan gigi. Penggunaan tembakau pada remaja berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit periodontal dan kerusakan gigi (Kusumawati et al., 2019). Gaya hidup yang kurang aktif dapat berkontribusi pada masalah kesehatan secara umum, termasuk kesehatan gigi. Kurangnya aktivitas fisik pada anak dapat berhubungan dengan pola makan yang buruk, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan gigi (Sari et al., 2021). Ngemil secara berlebihan, terutama makanan yang tidak sehat, dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Anak-anak yang sering ngemil antara waktu makan cenderung memiliki lebih banyak masalah gigi dibandingkan dengan yang tidak (Hidayati et al., 2018). Kebiasaan mengisap jari dapat menyebabkan maloklusi dan masalah gigi lainnya. Mengisap jari pada anak dapat mengganggu pertumbuhan gigi permanen dan menyebabkan perubahan pada posisi gigi (Lestari et al., 2020).

F. Cara Menjaga Kesehatan Gigi Anak Anak dan Remaja

1. Menyikat gigi secara teratur

a. Waktu menyikat gigi

Anak dan remaja harus menyikat gigi setidaknya dua kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dapat membantu mencegah kerusakan gigi (Kemkes 2018).

b. Teknik menyikat gigi

Teknik menyikat gigi yang benar dengan menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Sikat gigi dengan gerakan lembut secara melingkar, mulai dari gigi bagian depan, kemudian ke gigi bagian belakang, dan jangan lupa menyikat lidah untuk menghilangkan bakteri (Siti Aisyah. 2019).

c. Waktu menyikat gigi

Waktu menyikat gigi sebaiknya dilakukan dua kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Ini membantu menghilangkan sisa makanan dan plak yang menempel di gigi (Kemenkes 2020).

d. Frekuensi menyikat gigi

Frekuensi menyikat gigi yang benar disarankan untuk menyikat gigi minimal

dua kali sehari, tetapi idealnya tiga kali setelah setiap kali makan, terutama

setelah makan makanan manis atau asam (IDGI. 2020).

2. Pemilihan pasta gigi yang tepat

Pilih pasta gigi yang mengandung fluoride, karena fluoride membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah kerusakan gigi (Kemenkes 2020). Jika memiliki masalah gigi tertentu, seperti gigi sensitif atau masalah gusi, pilihlah pasta gigi yang diformulasikan khusus untuk kondisi tersebut (IDGI,2019). Pastikan pasta gigi yang digunakan tidak mengandung gula tambahan untuk menghindari risiko kerusakan gigi (BPOM. 2021).

3. Penggunaan benang gigi

Benang gigi membantu membersihkan plak dan sisa makanan di antara gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), penggunaan benang gigi secara rutin dapat mengurangi risiko karies gigi dan peradangan gusi pada anak-anak dan remaja. Anak-anak bisa mulai menggunakan benang gigi sejak memiliki dua gigi yang saling bersentuhan. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) (2020) menyarankan agar orang tua membantu anak-anak dalam penggunaan benang gigi hingga mereka mampu melakukannya sendiri, sekitar usia 8–10 tahun. Direkomendasikan untuk menggunakan benang gigi setidaknya satu kali sehari, terutama sebelum tidur. Studi dari Badan Litbang Kesehatan (2021) menunjukkan bahwa remaja yang rutin menggunakan benang gigi memiliki tingkat kesehatan gusi yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan sikat gigi. Orang tua dan guru berperan penting dalam

membimbing anak-anak agar terbiasa menggunakan benang gigi dengan benar. Menurut modul edukasi kesehatan gigi dari Kemenkes RI (2020), anak yang mendapatkan edukasi dari orang tua dan guru cenderung lebih disiplin dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut.

4. Berkunjung ke Dokter Gigi

a. Deteksi dini masalah gigi dan mulut

Kunjungan rutin ke dokter gigi membantu mendeteksi masalah gigi dan mulut sejak dini, seperti karies, radang gusi, atau maloklusi. Kemenkes RI (2018) deteksi dini sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius dan membutuhkan perawatan yang lebih mahal.

b. Mencegah dan Mengobati Karies Gigi

Kunjungan rutin ke dokter gigi membantu mendeteksi masalah gigi dan mulut sejak dini, seperti karies, radang gusi, atau maloklusi. Kemenkes RI (2018) deteksi dini sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius dan membutuhkan perawatan yang lebih mahal.

Karies gigi adalah salah satu masalah kesehatan gigi yang paling umum terjadi pada anak-anak dan remaja. (Balitbangkes) Kemenkes RI (2019) melaporkan bahwa 93% anak usia 5-6 tahun di Indonesia mengalami karies gigi, dan sebagian besar tidak mendapatkan perawatan yang memadai.

- c. Pentingnya pembersihan profesional (Scaling dan Fluoride Treatment)
Dokter gigi dapat melakukan pembersihan plak dan karang gigi yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan menyikat gigi. (PDGI, 2020) menyatakan bahwa scaling gigi secara rutin dapat mengurangi risiko radang gusi dan periodontitis pada remaja.
- d. Edukasi dan kebiasaan menjaga kesehatan gigi
Kunjungan ke dokter gigi memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk mendapatkan edukasi mengenai teknik menyikat gigi yang benar dan pola makan sehat untuk gigi. Menurut modul edukasi Kemenkes RI (2021). anak-anak yang mendapatkan bimbingan dari dokter gigi cenderung lebih rajin menyikat gigi dengan cara yang benar dibandingkan yang tidak mendapatkan edukasi.
- e. Pemantauan perkembangan gigi dan rahang
Dokter gigi dapat memantau perkembangan gigi dan rahang, terutama saat anak-anak mulai mengalami pergantian gigi susu ke gigi permanen. Studi oleh Sunarto, A. (2022) menunjukkan bahwa kunjungan rutin ke dokter gigi sejak usia dini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan perawatan ortodontik pada remaja.
- f. Mengatasi kebiasaan buruk
Beberapa kebiasaan buruk seperti menggigit kuku, mengisap jempol, atau mengunyah es batu dapat merusak kesehatan gigi dan perlu dikonsultasikan ke

dokter gigi. Menurut penelitian Susanto, R. (2023) anak-anak yang mendapatkan bimbingan langsung dari dokter gigi lebih mudah menghilangkan kebiasaan buruk yang berpotensi merusak gigi.

g. Mencegah ketakutan terhadap perawatan gigi

Anak-anak yang terbiasa berkunjung ke dokter gigi sejak dini akan lebih nyaman dan tidak takut saat menjalani perawatan gigi. Kemenkes RI (2020), pengenalan lingkungan dokter gigi sejak usia dini membantu anak-anak mengurangi kecemasan dan membentuk kebiasaan baik dalam perawatan kesehatan gigi.

h. Pemeriksaan gigi secara berkala

Disarankan untuk melakukan kunjungan ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali, meskipun tidak ada keluhan. PDGI (2021), pemeriksaan rutin membantu menjaga kesehatan gigi jangka panjang dan mengurangi risiko masalah gigi di kemudian hari.

5. Menghindari makanan dan minuman yang merusak gigi.

a. Makanan dan Minuman Manis

Batasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, seperti permen, kue, dan minuman bersoda. Gula dapat berfermentasi oleh bakteri di mulut dan menghasilkan asam yang merusak enamel gigi (Kemenkes 2020).

b. Makanan asam

Hindari makanan dan minuman yang tinggi asam, seperti jeruk, lemon, cuka, dan minuman energi. Asam dapat melemahkan enamel gigi, yang meningkatkan risiko erosi gigi (IDGI 2019).

c. Makanan keras

Hindari mengonsumsi makanan yang keras seperti es batu, kacang-kacangan keras, dan permen keras. Makanan ini dapat menyebabkan patah atau retak gigi (Kemenkes 2018).

d. Minuman berkarbonasi

Minuman berkarbonasi mengandung asam karbonat dan sering kali juga mengandung gula, yang berkontribusi terhadap kerusakan gigi. Sebaiknya pilih air mineral atau minuman tidak berkarbonasi (BPOM 2021).

e. Konsumsi camilan sehat

Gantilah camilan tidak sehat dengan pilihan yang lebih sehat seperti buah-buahan segar, sayuran, atau yogurt. Ini membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut (Kemenkes 2020).

f. Minuman beralkohol dan merokok

Hindari konsumsi alkohol dan merokok, karena keduanya dapat merusak gusi dan jaringan mulut, serta meningkatkan risiko penyakit gigi (BNN 2021).

G. Membangun Rutinitas Perawatan Gigi Anak dan Remaja

Menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak usia dini sangat penting untuk mencegah berbagai masalah seperti

karies gigi dan penyakit gusi. Rutinitas perawatan gigi yang baik harus diterapkan oleh anak-anak dan remaja agar mereka memiliki kebiasaan sehat yang berkelanjutan.

Salah satu langkah utama dalam membangun kebiasaan perawatan gigi adalah mengajarkan teknik menyikat gigi yang benar. Menurut Sutrisno, A. (2020) menyikat gigi dengan gerakan memutar dan tekanan yang tidak terlalu kuat dapat mencegah kerusakan enamel serta mengurangi risiko peradangan gusi. Selain teknik yang benar, konsistensi dalam waktu menyikat gigi juga berperan penting. Hidayat, R. (2019) menegaskan bahwa menyikat gigi dua kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur, dapat membentuk kebiasaan yang baik dan efektif dalam menjaga kesehatan gigi.

Selain menyikat gigi, penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride sangat dianjurkan. Widodo, B. (2021) menyebutkan bahwa fluoride mampu memperkuat enamel dan melindungi gigi dari karies. Tidak hanya itu, penggunaan benang gigi juga perlu diperkenalkan sejak dini. Berdasarkan penelitian Susanto, R. (2022) remaja yang rutin menggunakan benang gigi memiliki kesehatan gusi yang lebih baik dibandingkan yang hanya mengandalkan sikat gigi.

Pola makan juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan gigi. Konsumsi makanan bergizi seperti susu dan sayuran hijau dapat mendukung pertumbuhan gigi yang kuat. Lestari, D. (2020) menunjukkan bahwa anak-anak yang menghindari makanan manis dan tinggi gula memiliki risiko

lebih rendah terhadap karies gigi. Sebaliknya, konsumsi berlebihan gula dapat mempercepat kerusakan gigi. Suryani, T. (2021) menjelaskan bahwa permen dan minuman bersoda meningkatkan pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang jika tidak diimbangi dengan kebiasaan membersihkan gigi yang baik.

Untuk memastikan kesehatan gigi tetap optimal, anak-anak dan remaja juga harus dibiasakan berkumur setelah makan guna menghilangkan sisa makanan di sela-sela gigi. Wahyuni, S. (2020) menemukan bahwa anak yang rutin berkumur setelah makan memiliki tingkat kesehatan gigi yang lebih baik dibandingkan yang tidak melakukannya. Selain itu, kunjungan ke dokter gigi secara rutin minimal setiap enam bulan sekali sangat dianjurkan. Prasetyo, M. (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan berkala dapat membantu mendeteksi masalah gigi sejak dini dan mencegah kondisi yang lebih serius.

Orang tua memiliki peran besar dalam membantu anak-anak membangun kebiasaan perawatan gigi. Fitriani, L. (2019) menyebutkan bahwa anak-anak yang didampingi orang tua dalam menyikat gigi lebih disiplin dan konsisten dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan. Oleh karena itu, edukasi sejak dini serta peran aktif orang tua sangat diperlukan agar anak-anak dan remaja memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan gigi mereka.

Dengan membangun kebiasaan yang baik dalam perawatan gigi sejak dini, anak-anak dan remaja dapat terhindar dari berbagai masalah gigi yang umum terjadi.

Konsistensi dalam menyikat gigi, penggunaan benang gigi, pola makan yang sehat, serta kunjungan rutin ke dokter gigi adalah langkah-langkah utama yang dapat memastikan gigi tetap sehat hingga usia dewasa.

H. Mengajarkan Anak Disiplin dalam Menjaga Kesehatan Gigi

Menjaga kesehatan gigi merupakan kebiasaan yang perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak terbiasa merawat gigi mereka dengan baik. Disiplin dalam menjaga kebersihan gigi tidak hanya mencegah berbagai masalah seperti karies dan radang gusi, tetapi juga membentuk pola hidup sehat hingga dewasa. Untuk mencapai hal ini, orang tua dan pendidik perlu menerapkan berbagai strategi agar anak-anak lebih sadar dan terbiasa merawat kesehatan gigi mereka.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membiasakan anak menyikat gigi secara teratur. Hidayat, R. (2019) menjelaskan bahwa menyikat gigi dua kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur, merupakan cara efektif untuk menjaga kebersihan gigi anak-anak. Namun, menyikat gigi saja tidak cukup jika teknik yang digunakan tidak benar. Oleh karena itu, anak-anak harus diajarkan cara menyikat gigi dengan gerakan yang tepat. Sutrisno, A. (2020) menegaskan bahwa teknik menyikat gigi yang benar dapat meningkatkan efektivitas pembersihan plak dan mengurangi risiko radang gusi.

Selain mengajarkan teknik menyikat gigi, orang tua juga perlu memberikan contoh langsung. Anak-anak cenderung meniru kebiasaan orang tua, termasuk dalam menjaga kesehatan gigi. Menurut Fitriani, L. (2019) anak-anak yang melihat orang tuanya rutin menyikat gigi akan lebih termotivasi untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Agar lebih menarik, penggunaan media edukasi seperti video animasi, lagu, atau buku cerita tentang kesehatan gigi juga dapat membantu. Wahyuni, S. (2021) menyebutkan bahwa metode edukatif berbasis media lebih efektif dibandingkan metode ceramah dalam meningkatkan kesadaran anak tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi.

Selain menyikat gigi, anak-anak juga perlu diajarkan penggunaan benang gigi. Susanto, R. (2022) menemukan bahwa anak-anak yang terbiasa menggunakan benang gigi sejak dini memiliki kebersihan mulut yang lebih baik saat mereka beranjak remaja dibandingkan anak-anak yang hanya mengandalkan sikat gigi. Untuk meningkatkan motivasi anak dalam menjaga kesehatan gigi, pemberian penghargaan juga bisa menjadi strategi yang efektif. Prasetyo, M. (2021) dalam menyatakan bahwa sistem penghargaan seperti stiker atau bintang dapat membantu anak lebih disiplin dalam menyikat gigi.

Di samping kebiasaan menyikat gigi, pola makan juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan gigi. Anak-anak harus dibiasakan untuk mengonsumsi makanan sehat yang baik untuk gigi, seperti susu dan sayuran hijau, serta membatasi makanan manis. Suryani, T. (2021)

menjelaskan bahwa konsumsi gula berlebihan tanpa diimbangi dengan kebersihan gigi yang baik dapat meningkatkan risiko karies gigi. Untuk mendukung kebiasaan baik ini, anak juga perlu diajarkan berkumur dengan air putih setelah makan agar sisa makanan di sela-sela gigi bisa berkurang. Wahyuni, S. (2020) menemukan bahwa anak yang rutin berkumur setelah makan memiliki risiko lebih rendah mengalami karies dibandingkan yang tidak melakukannya.

Selain kebiasaan di rumah, anak-anak juga harus dibiasakan berkunjung ke dokter gigi secara rutin. Widodo, B. (2021) menyarankan agar anak-anak diperiksa ke dokter gigi setiap enam bulan sekali untuk mendeteksi potensi masalah gigi sejak dini dan mendapatkan perawatan pencegahan seperti fluoride atau pembersihan plak. Penggunaan pasta gigi berfluoride juga sangat dianjurkan karena dapat membantu memperkuat enamel gigi. Lestari, D. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan pasta gigi berfluoride secara rutin dapat mengurangi risiko gigi berlubang hingga 40% pada anak-anak.

Agar kebiasaan menjaga kesehatan gigi dapat berlangsung dalam jangka panjang, perawatan gigi harus menjadi bagian dari rutinitas harian anak-anak. Sunarto, A. (2022) menyatakan bahwa anak yang menjadikan perawatan gigi sebagai bagian dari rutinitas harian mereka cenderung lebih konsisten dalam menjaga kebersihan gigi hingga dewasa.

Secara keseluruhan, mengajarkan anak disiplin dalam menjaga kesehatan gigi membutuhkan kombinasi edukasi, contoh nyata dari orang tua, serta kebiasaan baik yang terus diperkuat setiap hari. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, anak-anak dapat tumbuh dengan gigi yang sehat dan memiliki kebiasaan kebersihan gigi yang baik sepanjang hidup mereka.

I. Peran Orang Tua dan Guru dalam Edukasi Kesehatan Gigi Anak dan Remaja

Menanamkan kebiasaan menjaga kesehatan gigi sejak usia dini sangat penting untuk mencegah berbagai masalah gigi dan mulut di kemudian hari. Orang tua dan guru memiliki peran utama dalam mendidik anak-anak dan remaja agar mereka memahami pentingnya menjaga kebersihan gigi serta membangun kebiasaan baik yang dapat bertahan seumur hidup. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak akan lebih disiplin dalam merawat kesehatan gigi mereka.

1. Memberikan contoh langsung

Anak-anak dan remaja cenderung meniru kebiasaan orang tua dan guru dalam kesehariannya, termasuk dalam menjaga kebersihan gigi. Jika orang tua terbiasa menyikat gigi dengan baik, anak-anak akan lebih mudah meniru kebiasaan tersebut. Fitriani, L. (2019) menegaskan bahwa anak yang melihat orang tua mereka rutin menyikat gigi akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama.

2. Membangun kebiasaan menyikat gigi secara teratur

Orang tua dan guru harus memastikan bahwa anak-anak memiliki kebiasaan menyikat gigi yang baik, yaitu minimal dua kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Hidayat, R. (2019) dmenjelaskan bahwa anak yang memiliki kebiasaan menyikat gigi sejak kecil lebih cenderung mempertahankan kebiasaan tersebut hingga dewasa.

3. Menggunakan media edukasi yang menarik

Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan remaja tentang pentingnya kesehatan gigi, orang tua dan guru dapat menggunakan media edukasi seperti video animasi, lagu, atau buku cerita yang menarik. Wahyuni, S. (2021) menemukan bahwa metode edukatif berbasis media lebih efektif dibandingkan metode ceramah dalam meningkatkan kesadaran anak tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi.

4. Mengajarkan teknik menyikat gigi yang benar

Orang tua dan guru harus mengajarkan cara menyikat gigi yang benar, termasuk durasi menyikat gigi yang ideal (minimal dua menit) serta penggunaan teknik memutar agar pembersihan lebih efektif. Sutrisno, A. (2020) menyebutkan bahwa anak-anak yang diajarkan teknik menyikat gigi yang benar memiliki risiko lebih rendah mengalami radang gusi dan karies gigi.

5. Mengajarkan penggunaan benang gigi sejak dini

Selain menyikat gigi, anak-anak dan remaja perlu diajarkan penggunaan benang gigi untuk membersihkan

sisia makanan di sela-sela gigi. Susanto, R. (2022) menemukan bahwa anak-anak yang rutin menggunakan benang gigi memiliki kesehatan gusi yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan sikat gigi.

6. Mengajarkan dampak pola makan terhadap kesehatan gigi

Guru dan orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak tentang makanan dan minuman yang dapat merusak gigi, seperti permen, soda, dan makanan tinggi gula. Suryani, T. (2021) menjelaskan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko gigi berlubang jika tidak diimbangi dengan kebiasaan menjaga kebersihan gigi yang baik.

7. Mengajak anak berkunjung ke dokter gigi secara rutin

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pemeriksaan gigi rutin setidaknya setiap enam bulan sekali. Widodo, B. (2021) menjelaskan bahwa anak yang terbiasa berkunjung ke dokter gigi sejak kecil akan lebih nyaman dengan perawatan gigi dan memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah gigi serius di kemudian hari.

8. Menjadikan kebersihan gigi sebagai bagian dari program sekolah

Sekolah dapat mendukung edukasi kesehatan gigi dengan memasukkan materi kesehatan gigi ke dalam kurikulum atau melalui program kesehatan sekolah.

Prasetyo, M. (2022) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki program edukasi kesehatan gigi berhasil meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan gigi dibandingkan sekolah yang tidak memiliki program serupa.

9. Mendorong anak untuk berkumur setelah makan

Orang tua dan guru dapat mengajarkan anak-anak untuk membiasakan berkumur setelah makan agar sisa makanan di sela-sela gigi tidak menyebabkan plak atau karies. Wahyuni, S. (2020) menemukan bahwa anak yang rutin berkumur setelah makan memiliki risiko lebih rendah mengalami karies dibandingkan mereka yang tidak melakukannya.

10. Memberikan penghargaan untuk kebiasaan baik

Agar anak-anak lebih termotivasi dalam menjaga kesehatan gigi, orang tua dan guru dapat menerapkan sistem penghargaan seperti memberikan pujian atau hadiah kecil. Prasetyo, M. (2021) menyatakan bahwa sistem reward dapat mempercepat pembentukan kebiasaan menyikat gigi secara rutin pada anak-anak.

Peran orang tua dan guru dalam edukasi kesehatan gigi anak dan remaja sangatlah penting. Orang tua dapat memberikan contoh, membangun kebiasaan sehat di rumah, dan memastikan anak-anak mendapatkan pemeriksaan gigi rutin. Sementara itu, guru dapat mendukung edukasi kesehatan gigi melalui kurikulum sekolah dan program kesehatan. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dan remaja dapat memiliki kebiasaan baik

dalam menjaga kebersihan gigi yang akan mereka pertahankan hingga dewasa.

J. Referensi

- Aji Satria (2024) Menenal Anatomi Gigi, Jenis, dan Fungsi Bagiannya: hello sehat 26/07/2024
- American Academy of Pediatric Dentistry. (2021). Oral Health Policies. Retrieved from aapd.org
- American Dental Association. (2018). Oral Health Topics. Retrieved from ada.org
- American Dental Association. (2020). "Oral Health Topics: Gum Disease." Retrieved from ada.org.
- Angle, E. H. (1899). "Classification of Malocclusion." *Dental Cosmos*, 41, 248-264.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2021). Laporan Tahunan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: BNN.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes RI (2019)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). (2021). Regulasi dan Informasi Produk Kesehatan. Jakarta: BPOM.
- Bader, J. D., & Shugars, D. A. (2004). "The Role of Radiographs in the Detection of Caries." *Journal of the American Dental Association*, 135(6), 776-784.
- Bishara, S. E. (1998). "Dental and Facial Aesthetic Considerations in Orthodontics." *American Journal*

- of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 113(1), 93-99.
- Bishara, S. E. (2001). "Management of Mixed Dentition Malocclusion." American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 120(3), 287-295.
- Buchalla, W., & Attin, T. (2007). "Clinical Applications of Fluoride." Dental Clinics of North America, 51(2), 457-471.
- Burt, B. A., & Pai, S. (2001). Sugar Consumption and Caries Risk: A Scientific Review. Journal of Dental Education, 65(10), 1017-1023.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Key Facts About the Oral Health of Children. Retrieved from [cdc.gov](https://www.cdc.gov)
- Cobb, C. M. (2002). "Non-surgical pocket therapy: An evidence-based perspective." Periodontology 2000, 30(1), 188-202.
- Dawes, C. (2004). "Salivary Flow Patterns and the Effects of Diet on Salivary Composition." Journal of Dental Research, 83(Special Issue), C39-C43.
- Dr. Siti Aisyah. (2019). Pedoman Menyikat Gigi yang Benar. Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut, Vol. 1(1), hlm.
- Fitriani, L. (2019) dalam *Peran Orang Tua dalam Membangun Kebiasaan Menyikat Gigi Anak*
- Fitzgerald, M., et al. (2015). "Dental Trauma in Children: A Review of 6 Years of Experience." Australian Dental Journal, 60(2), 149-154.

Gigi dan Mulut,

- Goyal, A., et al. (2015). Effectiveness of School-Based Dental Health Education Program. *Journal of Dental Research*, 94(2), 415-421.
- Gumus, P., et al. (2012). "The relationship between smoking and periodontal disease." *Journal of Clinical Periodontology*, 39(3), 272-277.
- Harris, R. J., et al. (2009). "The Role of Sugar-Sweetened Beverages in Childhood Obesity and Dental Caries." *Pediatrics*, 123(2), 557-564.
- Harrison, J. E., et al. (2015). "Oral Health and Quality of Life." *British Dental Journal*, 218(9), 489-495.
- Hassan, R., et al. (2020). The Role of Social Media in Health Promotion: A Study on Dental Health. *Journal of Public Health*, 28(4), 567-575.
- Hidayat, R. (2019) dalam buku *Pola Hidup Sehat Anak dan Remaja*
- Hidayati, N., et al. (2018). "Kebiasaan Ngemil dan Kesehatan Gigi Anak." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 80-85.
- Hidayati, N., et al. (2020). "Akses Layanan Kesehatan Gigi di Wilayah Pedesaan dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Gigi Anak." *Jurnal Kesehatan Gigi*, 9(2), 75-82.
- Huang, Y., et al. (2017). "The Prevalence of Dentin Hypersensitivity in Adolescents and Its Relation to Oral Health-Related Quality of Life." *BMC Oral Health*, 17(1), 95.

- Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI). (2019). Pedoman Kesehatan Gigi untuk Anak dan Remaja. Jakarta: IDGI.
- Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI). (2020). Pedoman Praktis Kesehatan Gigi. Jakarta: IDGI.
- Jensen, R. A., et al. (2004). "Genetic Factors in the Development of Malocclusion." *Orthodontics & Craniofacial Research*, 7(1), 1-10.
- Jiang, Y., et al. (2019). "Dental Caries: A Review of its Etiology and Prevention." *Journal of Dental Research*, 98(1), 77-84.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Kesehatan Gigi dan Mulut. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI (2018) dalam *Pedoman Pemeliharaan Kesehatan*
- Kohler, D. J., et al. (2009). "Speech and Malocclusion: A Review." *International Journal of Clinical Dentistry*, 2(1), 43-51.
- Kumar, S., et al. (2016). "Psychosocial Impact of Malocclusion in Children." *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry*, 34(2), 129-133.
- Kusumawati, R., et al. (2019). "Dampak Kebiasaan Merokok pada Kesehatan Gigi Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(1), 45-50.

- Lestari, D., et al. (2020). "Pengaruh Kebiasaan Mengisap Jari terhadap Kesehatan Gigi Anak." *Jurnal Kedokteran Gigi*, 3(1), 30-35.
- Litbang Kesehatan (2021)
- Löe, H. (2000). "Periodontal disease: A global risk factor for systemic diseases and conditions." *Journal of Periodontology*, 71(4), 457-460.
- López, R., et al. (2015). "Oral Health and Malocclusion among Children." *European Journal of Orthodontics*, 37(1), 27-34.
- Marinho, V. C., et al. (2003). "Fluoride Toothpastes for Preventing Dental Caries in Children and Adolescents." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1), CD002278.
- Marlina, R., & Amalia, N. (2021). "Pengaruh Kebiasaan Keluarga Terhadap Perilaku Menjaga Kebersihan Gigi Anak." *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 5(3), 200-206.
- Marsh, P. D. (2010). "Microbial Ecology of Dental Plaque and Its Significance in Health and Disease." *Advances in Dental Research*, 22(5), 44-48.
- Meyle, J., & Tetradis, S. (2015). "Periodontitis: A Multifactorial Disease of Tooth-Supporting Tissues." *Journal of Clinical Periodontology*, 42(S16), S3-S12.
- Moursi, A., et al. (2014). The Impact of Oral Health on Academic Performance in Adolescents. *Journal of Dental Research*, 93(3), 277-281.

- Moyers, R. E. (1988). Handbook of Orthodontics. Year Book Medical Publishers.
- Moynihan, P. J., & Kelly, S. A. (2014). "Effect on Caries of Restricting Sugars Intake." *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 42(2), 183-196.
- Niemann, N., et al. (2017). "Oral Health in Children: The Importance of a Good Dental Hygiene." *Journal of Pediatric Dentistry*, 45(4), 129-137.
- Nishida, M., & Hara, A. (2014). "Food, Nutrition, and Oral Health." *Journal of Dental Research*, 93(1), 104-109.
- O'Connell, A. C., et al. (2015). "Impact of Oral Health on Quality of Life." *Journal of Dental Research*, 94(7), 945-951.
- Page, R. C., & Kornman, K. S. (1997). "The Pathogenesis of Human Periodontal Disease: An Introduction." *Periodontology 2000*, 14(1), 9-11.
- Petersen, P. E., & Ogawa, H. (2012). "Strengthening the Prevention of Dental Caries in Children and Adolescents: The WHO Global Oral Health Program." *Caries Research*, 46(1), 1-8.

PDGI

- Petersen, P. E., et al. (2005). "Oral Health and the Quality of Life in Children." *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 33(1), 1-9.
- Prasetyo, M. (2021) dalam jurnal *Motivasi Anak dalam Menjaga Kesehatan Gigi*

- Prasetyo, M. (2022) dalam *Pentingnya Kunjungan Rutin ke Dokter Gigi pada Anak*
- Pratiwi, H. A., et al. (2020). "Pengetahuan dan Sikap Anak Terhadap Kesehatan Gigi di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Gigi*, 7(1), 45-50.
- Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2013). *Contemporary Orthodontics*. Elsevier Health Sciences.
- Rudolph, M. J., et al. (2010). "The Role of Cementum in the Longevity of Teeth." *Journal of Dental Research*, 89(5), 424-428.
- Rugg-Gunn, A. J. (2001). "Sugars and Dental Caries." *British Dental Journal*, 190(3), 158-162.
- Sanz, M., et al. (2018). "Periodontitis and cardiovascular diseases: A scientific statement from the European Federation of Periodontology." *Journal of Clinical Periodontology*, 45(5), 557-569.
- Sari, R. R., et al. (2021). "Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kesehatan Gigi pada Anak." *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 4(3), 150-156.
- Scully, C. (2013). "Oral and Maxillofacial Medicine: The Basis of Diagnosis and Treatment." Elsevier Health Sciences.
- Sunarto, A. (2022) dalam *Jurnal Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia*
- Suryani, E., et al. (2019). "Pentingnya Kebersihan Gigi dan Mulut untuk Kesehatan Anak." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 120-126.

- Suryani, T. (2021) dalam *Dampak Konsumsi Gula terhadap Kesehatan Gigi Remaja*
- Susanto, R. (2023) dalam *Dental Health Care Indonesia*,
- Sutrisno, A. (2020) dalam jurnal *Edukasi Kesehatan Gigi Anak Sekolah Dasar*,
- Ten Cate, J. M. (2008). Oral Histology: Development, Structure, and Function. 5th ed. St. Louis: Mosby.
- Tonetti, M. S., et al. (2017). "Periodontitis and Systemic Diseases: A Global Perspective." *Journal of Clinical Periodontology*, 44(S18), S106-S112.
- Wahyuni, S. (2020) dalam *Kebiasaan Sehat untuk Mencegah Karies Gigi pada Anak*
- Wahyuni, S. (2021) dalam jurnal *Strategi Edukasi Kesehatan Gigi bagi Anak Usia Dini*
- Widodo, B. (2021) dalam *Pentingnya Pemeriksaan Gigi Rutin pada Anak*
- Widyastuti, T., et al. (2018). "Frekuensi Menyikat Gigi pada Anak dan Hubungannya dengan Kesehatan Gigi." *Jurnal Kedokteran Gigi*, 1(1), 15-20.
- World Health Organization. (2019). Oral Health Fact Sheet. Retrieved from who.int
- Yuliana, M., et al. (2020). "Pengaruh Konsumsi Gula Terhadap Kesehatan Gigi Anak." *Jurnal Kesehatan Gigi*, 8(2), 101-106.

K. Glosarium

A

AADP = American Academy of Pediatric Dentistry.

ADA = American Dental Association.

B

Balitbangkes = Badan Penelitaian Pengembangan Kesehatan

BPOM = Badan Pengolahan Obat Dan Makanan

I

IDGI = Ikatan Dokter Gigi Indonesia

J

Junk Food= Makanan Cepat Saji

O

Ortodontik = Bidang Spesialis Berhubungan Denagan Proses Koreksi atau Membetulkan Kembali Posisi Gigi Yang Tidak Rapi

P

PDGI = Persatuan Dokter Gigi Indonesia

X

Xerostomia = Mulut Kering

PROFIL PENULIS



drg. Ika Ifitri, MDSc Lahir di Sei. Sarik, 21 September 1968. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Baiturrahmah, lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 MMPKG di Pasca Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali sebagai Dokter Gigi (PTT) pegawai Tidak Tetap di Puskesmas

Kamang Kabupaten Sawahlunto Sijunjung tahun 1998-2002. Tahun 2002 diangkat sebagai CPNS di Kemenken Poltekkes Padang sampai sekarang di Jurusan Kesehatan Gigi. Mengampu mata kuliah Dental Morfologi, Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi, Konservasi, Penatalaksanaan Konservasi, PKKB, IKGA, dan Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ika_ifitri@yahoo.com

Motto: "All you need is to give all you have"



PROFIL PENULIS



Merniwati Sherly Eluama, S.Kp.G., MDSc., Lahir di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, menyelesaikan masa studi Sekolah Dasar sampai Diploma 3 di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2008 melanjutkan studi S1 di Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi Universitas Gadjah Mada. Lulusan Magister Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2017. Saat ini aktif sebagai dosen Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Selain itu juga aktif pada organisasi profesi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Email: sherlyeluama@gmail.com dan HP.085239144207

PROFIL PENULIS



drg Arnetty, M.Kes., Lahir di Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat 24 Juli 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada FK Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995

sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Kumani Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1995. Pada tahun 1998 sebagai Dosen pada Universitas Baiturrahmah Padang. Pada tahun 1998 penulis sebagai dokter gigi di RS Bayangkara Padang. Saat ini penulis bekerja pada Kemenkes Poltekkes Padang dengan mengampu mata kuliah Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Manajemen Mutu, Exodonti. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dimana sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arnetty0724@gmail.com

Motto: "Find strength in adversity."

Buku *"Edukasi Kesehatan Gigi untuk Masyarakat"* hadir sebagai sumber informasi yang penting dan relevan dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi merupakan bagian integral dari kesehatan umum yang sering kali luput dari perhatian masyarakat luas. Melalui pendekatan edukatif yang sistematis, buku ini membahas berbagai aspek perawatan gigi yang ditujukan untuk berbagai kelompok usia.

Bab pertama mengulas secara mendalam mengenai bahaya kebiasaan buruk yang sering tidak disadari namun berpengaruh besar terhadap kerusakan gigi, seperti menggigit benda keras, kebiasaan merokok, serta pola konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Bab kedua difokuskan pada penyuluhan kesehatan gigi bagi lansia, yang sering kali menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga kebersihan dan fungsi rongga mulut. Sementara itu, bab ketiga ditujukan bagi anak-anak dan remaja, yang merupakan kelompok usia kritis dalam pembentukan kebiasaan dan kesadaran terhadap kesehatan gigi sejak dini.

Buku “Edukasi Kesehatan Gigi untuk Masyarakat” hadir sebagai sumber informasi yang penting dan relevan dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi merupakan bagian integral dari kesehatan umum yang sering kali luput dari perhatian masyarakat luas. Melalui pendekatan edukatif yang sistematis, buku ini membahas berbagai aspek perawatan gigi yang ditujukan untuk berbagai kelompok usia.

Bab pertama mengulas secara mendalam mengenai bahaya kebiasaan buruk yang sering tidak disadari namun berpengaruh besar terhadap kerusakan gigi, seperti menggigit benda keras, kebiasaan merokok, serta pola konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Bab kedua difokuskan pada penyuluhan kesehatan gigi bagi lansia, yang sering kali menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga kebersihan dan fungsi rongga mulut. Sementara itu, bab ketiga ditujukan bagi anak-anak dan remaja, yang merupakan kelompok usia kritis dalam pembentukan kebiasaan dan kesadaran terhadap kesehatan gigi sejak dini.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

